

Psychiatrie

Table des matières

Introduction et modèles de compréhension	6
Épidémiologie	6
Modèle de compréhension	7
<i>Modèle du sacré</i>	7
<i>Modèle biologique</i>	7
<i>Modèle sociologique</i>	7
<i>Modèles psychologiques</i>	7
Principaux syndromes psychiatriques adultes	9
Remarques préliminaires	9
Principaux syndromes chez l'adulte	9
<i>Troubles de l'humeur</i>	10
<i>Troubles psychotiques (rapport à la réalité)</i>	10
<i>Troubles anxieux</i>	10
<i>Addictions</i>	10
<i>Troubles de personnalité (relation)</i>	10
Nosologie	10
Troubles de l'humeur	11
Introduction	11
Épisode thymiques	11
<i>Épisode dépressif</i>	12
<i>Episode maniaque</i>	13
<i>Episode hypomaniaque</i>	14
<i>Episode mixte</i>	14
Dépressions	14
Types de dépressions	14
1. <i>Épisode dépressif majeur isolé</i>	14
2. <i>Trouble dysthymique</i>	15
3. <i>Troubles de l'adaptation</i>	16

Épidémiologie des troubles de l'humeur	16
Étiopathogénie	16
Complications et conséquences de la dépression	17
Traitement des dépressions	17
Troubles bipolaires	19
Types de troubles	19
<i>Trouble bipolaire de type 1</i>	19
<i>Trouble bipolaire de type 2</i>	19
<i>Trouble bipolaire avec cycles rapides</i>	19
<i>Cyclothymie</i>	19
Diagnostic	19
<i>Épisode maniaque</i>	19
Épidémiologie	20
Traitement	20
Troubles du spectre de la schizophrénie	22
Troubles psychotiques	22
<i>Délire</i>	22
<i>Hallucinations</i>	22
<i>Troubles du moi</i>	22
<i>Troubles formels du cours de la pensée</i>	23
Formes principales des troubles psychotiques	23
<i>Trouble schizo-affectif</i>	23
<i>Troubles psychotiques aigus et transitoires</i>	23
<i>Trouble délirant induit ou folie à deux</i>	24
<i>Psychose du post-partum</i>	24
<i>Trouble délirant persistant</i>	24
Schizophrénies	24
<i>Symptômes positifs</i>	25
<i>Symptômes négatifs</i>	25
<i>Troubles cognitifs</i>	25
Épidémiologie et étiopathogénie	26

Intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques	27
Témoignage de patient	30
Troubles anxieux	31
Introduction	31
Nosologie des troubles anxieux	32
<i>Attaque de panique</i>	32
<i>Trouble panique</i>	32
<i>Agoraphobie</i>	33
<i>Phobies spécifiques</i>	33
<i>Phobie sociale</i>	33
<i>Trouble obsessionnel-compulsif</i>	34
<i>Anxiété généralisée</i>	34
<i>Troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse</i>	35
Traitements	35
Etats de stress et réactions post-traumatiques	35
<i>Etat de stress aigu</i>	35
<i>État de stress post-traumatique</i>	36
Troubles de la personnalité	37
Tempérament, caractère et personnalité	37
Nosologie	37
Diagnostic	39
Groupe A : Bizarres et excentriques	39
<i>Personnalité paranoïaque</i>	39
<i>Personnalité schizoïde</i>	39
<i>Personnalité schizotypique</i>	39
Groupe B : dramatiques	40
<i>Personnalité anti-sociale</i>	40
<i>Personnalité borderline</i>	40
<i>Personnalité histrionique</i>	41
<i>Personnalité narcissique</i>	41
Groupe C : anxieux	41

<i>Personnalité évitante</i>	41
<i>Personnalité dépendante</i>	41
<i>Personnalité obsessionnelle compulsive</i>	42
Les addictions	42
Contexte et vignettes cliniques	42
Type de substances et d'addictions	43
<i>Psycholeptiques</i>	43
<i>Psychoanaleptiques</i>	43
<i>Psychodysleptiques</i>	43
<i>Comportements addictifs</i>	43
Classification et diagnostic	44
Fondements neurobiologiques	45
Crise suicidaire	46
Épidémiologie	46
Caractéristiques du passage à l'acte suicidaire selon le trouble psychiatrique sous-jacent	46
<i>Troubles affectifs et suicide</i>	46
<i>Suicide et alcool</i>	46
<i>Suicide et schizophrénie</i>	46
<i>Suicide et troubles de la personnalité</i>	46
<i>Suicide et santé physique</i>	46
Modèles explicatifs	46
Prise en charge	47
Anti-dépresseurs et anti-psychotiques	49
Anti-psychotiques : mécanismes et cibles	49
Antipsychotiques typiques	50
Neuroleptiques atypiques	51
Anti-dépresseurs : principes et cibles	52
Les anti-dépresseurs	53
Lithium	55
Durée des traitements	55

Psychothérapies	56
Qu'est-ce qu'une psychothérapie ?	56
Naissance de la psychothérapie	56
Psychothérapies reconnues par la FMH et la FSP	57
<i>Psychothérapie psychanalytique</i>	57
<i>Psychothérapie TCC</i>	58
<i>Psychothérapie systémique</i>	58
Analyse de vidéo (série "in treatment")	58
Efficacité des psychothérapies	59
Autres approches thérapeutiques	60
Modèle bio-psycho-social	60
Coordination des soins : réseau	61
Traitement non-volontaire	61
Recherche translationnelle en psychiatrie	63
Contexte	63
Limitation en psychiatrie clinique contemporaine	63
Conclusions	64

Introduction et modèles de compréhension

Épidémiologie

Les pathologies psychiatriques sont **fréquentes** et leur poids dans la santé publique est **important**.
=> **17%** de prévalence par an de trouble psychiatrique dans la population (vs 7% pour le diabète, 0.3% pour le VIH par exemple)

DALY = YLL (années de vie perdue par mort prématurée) + YLD (années de vies perdues par invalidité).

En Europe, 20% des DALYs sont dues aux pathologies mentales ; 12% dans le monde (moins de mortalité de cause psy dans les pays en développement). Les troubles psy sont les causes de handicap les plus importants.

Les pathologies psychiatriques touchent tous les âges, et touchent beaucoup les jeunes (particulièrement la schizophrénie et les TOC) => 60 à 70% des DALYs chez les 25-34ans. Plus la prise en charge est précoce, plus les chances de rémission sont grandes.

Schizophrénie: 0.8% de prévalence annuelle, incidence à 0.02% (70'000 personnes en Suisse) => coût annuel total estimé à 3mia de francs.

On estime que les troubles psy représentent 13% des coûts globaux de la santé.

De plus, les comorbidités sont nombreuses et fréquentes, et la charge pesant sur les proches peut aussi conduire à d'autres pathologies somatiques ou psy, et/ou un certain degré d'invalidité.

Besoins de traitements et traitements délivrés

Il existe un écart important entre besoin et ressources, même dans les pays développés comme la Suisse. Il y a ainsi **35 à 50% de cas qui ne reçoivent pas de traitement** dans les pays développés, et jusqu'à 76 à 85% dans les pays en développement.

Différentes causes : non accès aux soins, non reconnaissance du problème, stigmatisation des soins psychiatriques...

Les points à retenir:

1. La prévalence des maladies psychiatriques est très élevée: Elles sont parmi les causes principales d'invalidité et la cause principale d'invalidité chez les jeunes
2. Elles se trouvent dans toutes les couches socio-économiques de la société
3. Le coût de leur prise en charge est élevé
4. Ecart marqué entre les besoins financiers et les investissements budgétaires. Causes: Maladies mal connues, stigmatisées, mal défendues et considérées à tort comme impossibles à traiter.

Modèle de compréhension

Deux manières de donner sens à des troubles:

1. Conception de ce qu'est le psychisme sur la base d'une compréhension religieuse, philosophique ou psychologique
2. **Sérendipité** : Observation de l'*effet* de substances ou approches sur des maladies pour les comprendre.

Les approches thérapeutiques dépendant du modèle conceptuel.

- Sacré => chamanisme, exorcisme
- Biologique => psychotropes, électrochocs...
- Psychologique => psychothérapies
- Sociologiques => modification des structures sociales (macro ou micro)

Modèle du sacré

Renvoie à des notions de **faute**, de possession, d'élection divine ("Je suis appelé par Dieu..."). Explication utile à un certain rééquilibrage, souvent pris par les patients et les proches, mais peu dans les conceptions contemporaines des soignants en Occident.

Il est probablement à la base de la stigmatisation de la maladie mentale et de la culpabilité pesant sur les proches.

=> s'y intéresser dans la prise en charge des patients et de leurs proches, car c'est peut-être leur seul modèle de compréhension.

Modèle biologique

Dans sa forme "dure" : toutes les manifestations du psychisme peuvent être réduites à la physiologie du SNC. Les pathologies sont donc liées à des dysfonctionnements du cerveau et les diagnostics se posent sur la base de l'identification de ces mécanismes.

Une majorité des maladies ne sont cependant pas expliquées par ce modèle. La psychologie est donc également liée à ce modèle pour expliquer les maladies.

Tout de même, actuellement, "molecular psychiatry" est le journal de psychiatrie le plus reconnu aujourd'hui (a dépassé les journaux de psychanalyse).

Modèle sociologique

Dans sa forme "dure": toutes les pathologies psychiatriques ne sont que des symptômes révélateurs de situations sociales (collectives et/ou individuelles) qui définissent ou conduisent l'individu à la déviance. "Les "fous" sont les sages d'une société malade".

=> en effet, les facteurs sociaux sont des importants co-déterminants des troubles mentaux.

Modèles psychologiques

A nouveau, la forme dure considère que le corps n'est qu'un élément statique et figé et que l'esprit en est détaché. La forme plus flexible y intègre la neurobiologie.

Trois axes (= trois axes dans la formation FMH)

1. Psychanalytique, 2. Cognitivo-comportemental. 3. Systémique

1. Modèle psychanalytique

Trois instances:

- Ça (pulsions, inné). Éros et thanatos, libido et pulsion de mort.
- Surmoi (ce que les parents nous ont induits, valeurs acquises)
- Moi (entre les deux, décision)

Les pathologies psychiques sont les manifestations des conflits entre ces instances (pulsions du ça, pression de contrôle du surmoi, nécessité de décision du moi) => mobilisation des mécanismes de défense garantissant l'équilibre du moi. Plus le stress est intense, plus les mécanismes de défense sont archaïques.

2. Modèle cognitivo-comportemental

Né de la frustration face à la non-efficacité présente parfois avec la psychanalyse (compréhension intellectuelle du problème mais sans changement).

Développé à partir de travaux sur le conditionnement, postule l'existence de **schémas de pensées** traitant l'information, qui se renforcent progressivement au cours de la vie.

Thérapie cognitive: cible les modifications pathologiques du traitement de l'information (biais d'interprétation, schémas défavorables).

Thérapies comportementales: désapprentissage de symptômes et comportements pathologiques (déconditionnement, désensibilisation par immersion)

Actuellement, le modèle TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale) se base sur ces deux aspects.

3. Modèle systémique

Développé par des psychanalystes qui réalisent l'importance de prendre en compte les influences extérieures dans la prise en charge des patients. Peut s'appliquer à la famille ou aussi aux différents réseaux dans lesquels le patient est inséré.

Un consensus de plus en plus large se forme autour de l'idée que ces modèles sont complémentaires : c'est le modèle **bio-psycho-social** (d'où le modèle sacré a pratiquement été exclu).

Selon le thérapeute et selon le patient, on préférera l'un ou l'autre de ces modèles. On peut aussi les combiner, par exemple psychothérapie + anti-dépresseurs.

Take home messages :

1. Selon la conception que l'on a de la maladie mentale, les modèles et les approches thérapeutiques varient.
2. Les modèles explicatifs principaux sont :
 1. Modèle du sacré
 2. Modèle biologique
 3. Modèle sociologique
 4. Modèle psychologique
 - a. Psychanalytique
 - b. Cognitivo-comportementaliste
 - c. Systémique
3. Il existe encore des puristes mais dans la psychiatrie moderne on mélange les inspirations de trois de ces modèles
4. Il est important de prendre en compte le modèle explicatif du patient de manière à s'adapter à ses besoins.

Principaux syndromes psychiatriques adultes

Remarques préliminaires

Alors qu'en médecine somatique, la distinction entre symptômes et signes est relativement évidente, la distinction est beaucoup plus floue en psychiatrie.

La sémiologie apparaît toujours dans le cadre d'une **relation** interpersonnelle. Ainsi, le contexte a une forte influence sur l'examen psychique des patients, et de plus, on prend aussi en compte ses propres réactions (contre-transfert) pour construire un diagnostic.

Limite entre normal et pathologique

Il est difficile de fixer un seuil quantitatif normal pour les émotions.

Le caractère pathologique d'une manifestation dépend également du contexte relationnel et culturel, la souffrance que cette manifestation induit chez l'individu, son apparition au sein d'un ensemble syndromique de manifestations.

Exemple: une même manifestations, normale ou pathologique

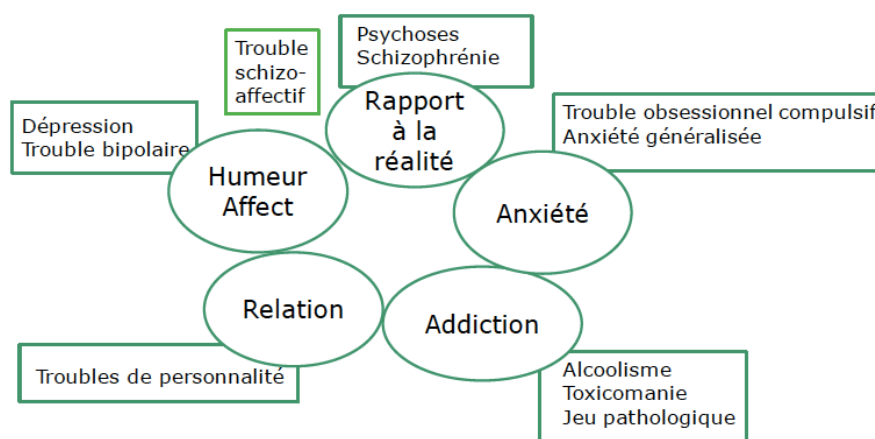
« Je suis très triste parce que mon grand-père est décédé hier soir. »

« Depuis quatre mois que j'ai dû aller vivre à Glasgow pour mon travail, je me sens triste tous les soirs et je n'ai même pas envie de regarder la TV. »

« Depuis que j'ai perdu mon emploi, je me sens triste, j'ai l'impression de ne rien valoir, je n'ai pas l'énergie pour rechercher un travail, je mange peu, et je me réveille toutes les nuits vers 4 heures du matin. »

Principaux syndromes chez l'adulte

Classification en fonction des domaines perturbés :



Le système AMDP est une sorte de "dictionnaire" des divers symptômes et est utile pour les diagnostic.

Troubles de l'humeur

Dépression: Humeur déprimée, perte d'espoir, sentiment d'insuffisance, de culpabilité ou voire de ruine (impression d'avoir un effet néfaste sur l'environnement), solitude, isolement, et troubles cognitifs (troubles de la mémoire, de la concentration).

Manie : Dysphorie (mauvaise humeur permanente), irritabilité, agitation intérieure, labilité affective, euphorie, accélération de la pensée, augmentation de l'énergie, perte de la nécessité de sommeil, etc.

La transition entre les deux phases peut être lente ou soudaine, ou elles peuvent être liées dans une phase intermédiaire (où le risque suicidaire est le plus élevé).

Troubles psychotiques (rapport à la réalité)

Délire systématisé ou non, défini selon son contenu (mystique, de persécution, de ruine, hypochondriaque, de grandeur, idées de concernement (= le monde centré sur moi)...).

Troubles de **perception** : illusions ou hallucinations, sénesthésies (hallucinations tactiles).

Troubles du **moi** : dépersonnalisation, déréalisation, devinement de la pensée, vol de la pensée (les pensées sont volées ou prélevées), pensées imposées (influencées, fabriquées, dirigées, gouvernées..).

Troubles formels du **cours de la pensée**: pensée ralentie, circonstanciée, fuite des idées, réponses à côté, néologismes. On ne comprend parfois pas du tout de quoi parle le patient.

Troubles anxieux

Préoccupations anxieuses *non-délirantes* (parfois difficile à distinguer) qui déterminent parfois le comportement. Devient pathologique si influence le comportement quotidien et empêche le fonctionnement normal.

- **Méfiance** non-délirante : Attitude soupçonneuse, tantôt anxieuse, tantôt hostile, entourage perçu comme malveillant...
- **Phobies**: peur de certaines situations ou objets, qui mènent à des conduites d'évitement.
- **Obsessions**: Idées et représentations qui s'imposent de manière répétée et sont vécues comme absurdes.
- **Compulsions**: Conduites que le sujet accomplit toujours sous la force de contraintes intérieures obsédantes (se rend compte que c'est absurde, mais ne peut pas les éviter).

Addictions

Cf cours spécifique

Troubles de personnalité (relation)

Dépendance, actes hétéro et auto-agressifs, tendances à l'agir et l'impulsivité.

Remarques

Les symptômes ne sont pas propres à un seul diagnostic. Exemple de la dépression: présente dans les troubles dépressifs, mais aussi dans les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Idem pour les troubles psychotiques, présents dans la schizophrénie mais aussi dans les troubles bipolaires, dépressifs et d'origine biologique.

Nosologie

La plupart des maladies n'étant pas expliquées, on parle de **syndromes**.

La classification est importante pour pouvoir faire une épidémiologie cohérente, d'où la création du DSM. La classification CIM-10 est celle de l'OMS, et sur laquelle le cours est fondé. Ce ne sont que des classifications, et en tout cas pas des manuels de psychiatrie!

Troubles de l'humeur

Introduction

Objectifs de ce cours : Connaître les catégories, les sémiologies et critères diagnostiques et le type de traitement adaptés à chaque trouble. En présence d'un résumé de cas, être en mesure de repérer les symptômes pertinents, établir un DD et proposer des hypothèses diagnostiques.

Émotion et humeur

Humeur (=thymie) : émotion qui se prolonge. Les variations de l'humeur sont normales.

L'humeur et sa variation sont pathologiques quand elles sont : **intenses, prolongées, entraînant une souffrance significative** (patient et/ou entourage), avec un **retentissement** sur la vie sociale et professionnelle.

De la dépression à la mélancolie

La dépression concerne 7% de la population suisse chaque année, soit **30%** des consultations en médecine générale.

Elle est **récurrente** dans 50% des cas, et devient chronique dans 15-30% des cas.

Elle est handicapante (10-30% des AI) et létale (suicide et accidents + 10-15%).

Elle est fortement liée à des comorbidités (cause, conséquence, cause commune ?).

Mélancolie : ancienne dénomination, liée à la théorie de l'humeur. Signifie "bile noire".

II^{ème} siècle après JC, Arétée de Cappadoce décrit la mélancolie (dépression) opposée à manie (maniaco-dépression).

Le mot **dépression** est utilisé à partir du 20^{ème} siècle, d'abord en physique (creux dans une surface) et d'autres domaines (géologie, météorologie, psychologie). Première utilisation en psychiatrie dans les années 1910.

Questions actuelles :

Le nombre de personnes déprimées aurait augmenté d'un facteur 10 entre 1960 et 2000. Cette augmentation est étroitement liée à l'invention des **antidépresseurs** et à son marketing.

Imipramine: découverte en 1957. Commercialisation de l'amytriptiline en 1961, mais en l'absence d'intérêt par la santé publique, l'entreprise lance une campagne de dépistage de la dépression. Idem en 1974, mais marché déclaré comme non-intéressant. En 1984, mise sur le marché du **Prozac**, qui connaît un succès fou.

La dépression, comme les autres maladies, sont aussi des **constructions sociales**.

Épisode thymiques

Les épisodes thymiques sont différentes manifestations de troubles de l'humeur. Les principaux sont dépression et manie. On distingue: **épisode dépressif majeur** (EDM), épisode **maniaque**, épisode **hypomaniaque** et épisode **mixte**.

Ce sont chacun des épisodes pouvant faire partie de différents syndromes ou maladies.

Ces maladies sont classées selon le DSM en troubles **dépressifs** et **troubles bipolaires**, avec différents catégories:

- Troubles dépressifs : EDM isolés ou récurrents, troubles dysthymiques, troubles de l'adaptation, troubles de l'humeur induits par une substance et troubles dépressif non-spécifié.
- Troubles bipolaires : I, II, cyclothymiques ou non-spécifiés.

Épisode dépressif

Symptômes psychiques

1. Douleur morale, humeur dépressive : pesanteur, vide, lenteur, émoussement affectif, anxiété, irritabilité, idées suicidaires. ≠ tristesse (émotion liée à un évènement, consolable, partageable)
2. Pessimisme, auto-dévalorisation, culpabilité, indignité
3. Anhédonie: incapacité à ressentir du plaisir à des activités habituellement plaisantes
4. Idées suicidaires.

Ces aspects psychiques sont rarement au premier plan de la présentation des patients.

Typiquement, le patient ne sait pas qu'il est déprimé. "Ca ne va pas, mais je ne sais pas ce que j'ai".

Symptômes psycho-moteurs

Ce sont les symptômes plus fréquemment présentés au cabinet :

5. Fatigue
6. Ralentissement ou agitation : perte d'élan vital, bradypsychie et -phémie (ralentissement des mots), aboulie (absence de volonté), faciès figé.

Autres symptômes :

7. Troubles de la concentration et de la mémoire
8. Insomnie ou hypersomnie
9. Anorexie et perte de poids ou prise de poids

Symptômes absents de la définition officielle, mais très pertinents (certains n'ont pas été mis pour ne pas stigmatiser):

- **Constipation** (très fréquente)
- Alcoolisation
- Douleurs fonctionnelles
- Troubles cognitifs (personne âgées)

Définition du DSM-IV

Cinq symptômes pendant au moins **deux semaines**, parmi :

1. Humeur dépressive
2. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée
3. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir (anhédonie)
4. Idées suicidaires récurrentes
5. Fatigue ou perte d'énergie
6. Agitation ou ralentissement psychomoteur
7. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision
8. Insomnie ou hypersomnie
9. Perte ou gain de poids significatif

NB: certains patients sont très **tolérants** à ces symptômes, d'autres pas du tout.
On les recherche à l'anamnèse spontanée et dirigée.

Dépression chez l'homme :

Les hommes ont moins de ressources pour exprimer le vécu dépressif. Il se manifestera alors plus sous forme d'**agitation**, irritabilité, fuite dans le travail, les drogues, l'alcool et plus souvent des **crises de colère**.

Episode maniaque

Symptômes psychiques

Humeur exaltée, euphorique, expansive.

Labilité et versatilité émotionnelle (joie, irritabilité, **agressivité**) => hospitalisation agitées!

Contact hypersyntonique (plus grande communicabilité)

Idées de **grandeur** psychotiques (délirantes), le plus souvent congruentes à l'humeur (thèmes mégalomaniaques) ou parfois non-congruentes à l'humeur (persécution, influence...).

Symptômes psychomoteurs

Activation psychique:

- Fuite des idées et tachypsychisme : Les pensées vont si vite que les paroles ne peuvent pas suivre.
- Confusions (phrases non-terminées, répétitions)
- Logorrhée, graphorée
- Distractibilité
- Ludisme et jeux de mots : Faux jeux de mots, plaisir à jouer avec les mots mais sans construction ni sens ("maître - mettre").

Activation motrice :

- Tachykinésie
- Hypermimie
- Désinhibition instinctivo-comportementale

Autres :

Désinhibition sociale et hypersexualité (=> *cave* MST)

Réduction du besoin de sommeil, insomnie

Anorexie et perte de poids (ou prise de poids)

L'épisode est ressenti comme un total bien-être par les patients, avec une forte résistance aux soins, qui sont nécessaires à cause des prises de risques.

Définition DSM

Période nettement délimitée, d'au moins **une semaine**, durant laquelle l'humeur est anormalement élevée ou irritable, avec au moins trois parmi les symptômes suivants :

1. Augmentation de l'estime de soi ou idée de grandeur
2. Plus grande communicabilité, désir de parler constamment (logorrhée)
3. Fuite des idées
4. Réduction du besoin de sommeil
5. Engagement excessif dans les activités agréables mais à potentiel élevée de conséquences dommageables (financières, sexuelles, etc.)

L'anamnèse **spontanée** est rarement pertinente. Le patient a souvent un déni de la maladie.

Se renseigner donc spécifiquement sur les comportements, le rythme veille-sommeil, les dépenses, les projets professionnels, etc. Une hétéro-anamnèse indirecte ("vous a-t-on fait des remarques sur...") et indirecte (contact avec un proche) peut être utile aussi.

DD épisode maniaque : consommation de coke.

Episode hypomaniaque

Etat maniaque mais d'intensité moindre, sans les symptômes psychotiques. L'altération du fonctionnement est faible à modérée (vs marquée), les erreurs de jugements sont moindres ou limitées, le traitement ambulatoire est fréquemment suffisant (vs hospitalisation nécessaire) et la régulation du sommeil par des benzodiazépines peut parfois aider à maîtriser les épisodes.

Episode mixte

Entre dépression et manie : réunit à la fois les critères pour les épisodes dépressifs et les épisodes maniaques, presque tous les jours et pendant au moins une semaine. Entraîne une altération marquée du fonctionnement et/ou nécessite une hospitalisation.

Dépressions

Types de dépressions

Ce sont des syndromes, composés d'épisodes dépressifs, sans épisodes maniaques ou mixtes.

Nosologie des troubles dépressifs :

- Troubles dépressifs majeurs, épisode isolé
- Trouble dysthymique
- Trouble de l'adaptation

Évolution et récurrence

15-30% des épisodes dépressifs majeurs deviennent **chroniques**. La durée d'un épisode est variable. Avec un traitement adéquat, la **rémission** totale est de **60-70%**.

50% de chance de récurrence au premier épisode, et le risque augmente avec le nombre de récurrences.

1. Épisode dépressif majeur isolé

Classification DSM :

- Sévérité : léger, moyen, grave. *Cave* ne sont pas des échelles diagnostiques (distribuées notamment par les pharmaco d'antidépresseurs).
- Caractéristiques **psychotiques**
- Forme : **catatonique, post-partum, mélancolique** et **atypique**
- Aigu / chronique (2ans)
- Dans les formes récurrentes: évolution **longitudinale** (rémission, dysthymie) ou caractère **saisonnier**

1.1 Forme psychotique

Symptômes psychotiques : Idées délirantes, éventuellement hallucinations, généralement **congruentes** à l'humeur: culpabilité, punition méritée, damnation, ruine, nihilisme du soi et du monde, pourrissement du corps, voix hostiles, accusatrices.

1.2 Forme catatonique

Ce n'est pas la forme la plus fréquente. Symptômes psycho-moteurs de **catatonie** :

- Immobilité motrice avec catalepsie (flexibilité cireuse)
- Négativisme, mutisme
- Stéréotypie gestuelle
- Echolalies, échopraxies

1.3 Dépression post-partum

- ≠ baby blues, qui est une sensibilité augmentée dans les jours de l'accouchement:
- Survient **2-3 semaines** après l'accouchement, pour 10% des femmes (selon les études).
 - Rechute pour 30% des femmes
 - Facteurs de risque : antécédents d'épisodes dépressifs, relation conjugale conflictuelle, manque de soutien social... Les grossesses sont souvent déclencheurs de réactivation dans la relation mère-fille (grand-mère du bébé).

1.4 Forme mélancolique

Forme la plus grave, avec douleur morale particulièrement intense et risque suicidaire élevé.

Pas de critères diagnostics clairs, surtout détectée avec expérience clinique.

Différents types : stuporeux, agité ou délirant.

1.5 Forme atypique

L'humeur plutôt que d'être dépressive, est surtout très **réactive**.

Le sujet est particulièrement sensible au rejet, et les symptômes s'aggravent le **soir**.

L'appétit est exagéré, avec un goût pour les aliments sucrés et une prise de poids.

La **libido** est augmentée.

Au niveau du sommeil, il y a une insomnie d'endormissement et une hypersomnie.

1.6 Forme saisonnière

Peut être isolée, ou partie d'autres épisodes dépressifs.

Présentation proche des formes atypiques :

- baisse de l'élan vital, ralentissement, asthénie, hibernation
- Appétit exagéré, fringale sucrée, prise de poids
- hypersomnie

Touche plus les jeunes et 4x plus les femmes.

Ttt : luminothérapie (probablement liée à la mélatonine), avec une bonne réponse thérapeutique.

2. Trouble dysthymique

Forme sub-syndromique, difficile à diagnostiquer. Caractérisé par une humeur dépressive.

Définition DSM:

Présence pratiquement toute la journée, plus d'un jour sur deux, pendant au moins **deux ans**, d'au moins **deux** des symptômes suivants :

1. Perte d'appétit ou hyperphagie
2. Insomnie ou hypersomnie
3. Baisse d'énergie ou fatigue
4. Faible estime de soi
5. Difficultés de concentrations ou à prendre des décisions
6. Sentiments de perte d'espoir

Évolution : 40% des patients développent un trouble uni- ou bipolaire. La mortalité par suicide est de 3-12%. Les hospitalisations sont fréquentes, et l'évolution sociale défavorable dans 60% des cas. La chronicité est beaucoup plus fréquente que pour les dépressions majeures (80% vs 15-30%). Elle peut évoluer en dépression majeure, et n'en ressortir qu'avec une rémission partielle. On parle alors de **dépression double**.

3. Troubles de l'adaptation

Lié fortement à un **évènement** déclencheur (au cours des 3mois qui suivent), mais pas moins grave qu'un épisode dépressif majeur (mêmes risques de complications), et pas forcément différent d'un épisode dépressif majeur.

Utilisation clinique pas claire. Gens jeunes, premier épisode avec déclencheur, pour ne pas stigmatiser. Peu utile, ambigu.

DD des dépressions :

- Causes somatiques : hypothyroïde, insuffisance surrénalienne, maladie neurologique, démence (âgé).
- Substance : médicaments, intoxication ou sevrage.
- Formes délirants ou stuporeuses : confusion (de cause somatique), troubles psychotiques (schizophrénie).
- Deuil.

Épidémiologie des troubles de l'humeur

Les chiffres à retenir :

Prévalence sur la vie entière de la dépression majeure : **20%** chez les femmes, **10%** chez les hommes. Sur une année : 10% chez les femmes, 5% chez les hommes.

Maximale entre 25 et 45 ans, mais début possible à tout âge.

Trouble bipolaire : 3-8% sur la vie entière.

Facteurs de risque pour la dépression

1. Hérité. NB :Vulnérabilité génétique à des maladies psychiatriques:
 - a. Trouble bipolaire, vulnérabilité génétique la plus forte (70% entre jumeaux mono-zygotes).
 - b. Schizophrénie (53%)
 - c. Dépression (**42%**)
2. Sexe (F>H)
3. Post-partum
4. Problèmes somatiques
5. Personnalité : perfectionnisme, hauts objectifs...
6. Niveau de formation bas
7. Contexte social : solitude, séparation, divorce, chômage, immigration
8. Évènements de vie (infantiles, actuels)

Étiopathogénie

Actuellement, on n'a aucun modèle explicatif plausible pour la dépression. On connaît certains facteurs psychologiques, sociaux, de la petite enfance, biologiques, etc. mais aucun n'est exclusivement causal.

Modèles biologiques

Anomalies fonctionnelles et structurelles: certains circuits cérébraux sont impliqués, mais ne sont pas des causes, uniquement des manifestations ou des caractéristiques.

Rôle des **amines** : les neurotransmetteurs sont impliqués aussi dans d'autres maladies (boulimie, trouble panique, TOC). On considère leur rôle en lien avec l'efficacité des anti-dépresseurs qui les favorisent. NB : La différence entre anti-dépresseurs et placebo est très faible (bien que significative).

Rôle du sommeil : les rythmes sont perturbés dans la dépression. La thérapie peut notamment se concentrer sur ceux-ci, notamment en favorisant la socialisation le matin.

Modèles psychologiques

Ils sont valides, mais ne représentent qu'un zoom sur une partie de la dépression. Ils sont notamment: Agressivité ressentie retournée contre soi, rupture d'un lien affectif (qui entretient l'estime de soi), estime de soi insuffisante, schémas cognitifs négatifs (surtout liés à l'entretien de la dépression, par sélection des événements négatifs).

Il existe donc de nombreux modèles sans idée actuelle pour les simplifier.

Complications et conséquences de la dépression

Les conséquences sont bien sûr familiales, sociales et professionnelles.

Le **suicide** est la complication majeure, chez **10-15% des patients**. On considère actuellement que 90% des suicides sont liés à des troubles psychiatriques (et donc une minorité des suicides dit "de bilan de vie", avant considérés comme majoritaires), dont **50% sont liés à la dépression** (35% aux troubles de la personnalité, 30% à l'alcoolisme et 6% à la schizophrénie).

=> c'est une faute de ne pas investiguer les idées suicidaires chez les patients déprimés. Aborder le sujet n'induit pas des idées suicidaires, contrairement à l'idée reçue.

A rechercher, dans l'ordre : Idée de mort, scénario, préparatifs, antécédents, abus de substances.

Des conséquences **médicales** apparaissent également :

- Problèmes somatiques, en particulier **douleurs**, qui sont souvent les symptômes prépondérants => diagnostic de douleur somatophore, pour laquelle l'AI ne donne pas de rente, contrairement à si le diagnostic de dépression est posé.
- Effets **IIres** des médicaments : agitation, troubles de l'appétit, baisse de la libido...

Les **comorbidités** sont fréquentes, en particulier avec les maladies cardio-vasculaires, les maladies neurologiques dégénératives (SEP, Parkinson) et les maladies métaboliques => rechercher la dépression avec ces maladies.

Traitement des dépressions

Aspects généraux (simples et évidents, mais difficiles à pratiquer en réalité):

Le traitement nécessite une bonne **coopération** entre médecin et patient, et pour cela, le médecin doit être capable de se mettre à la place du patient (ce qui est particulièrement difficile pour les pathologies psychiatriques) et donc d'accepter d'être un peu déprimé. Identifier, ne pas juger, "entendre une question ce n'est pas donner une réponse" : partager l'interrogation.

Le patient doit être **informé** : diagnostic, pronostic (la dépression se soigne dans 70% des cas) options thérapeutiques, durée et effets IIres des traitements.

La **relation** étant le principal outil, il faut lui donner un **cadre**, ce qui nécessite essentiellement du temps. Le plan de traitement consiste principalement en un calendrier d'entretiens établi au début.

Des entretiens de couple et de famille peuvent être utiles également.

L'objectif est la **rémission complète** des symptômes, et non juste une amélioration (=> chronicité!!).

Les modalités de traitement sont : médication, psychothérapie, combinaison des deux, luminothérapie, hospitalisation et ECT (électrocompulsivo-thérapie, uniquement pour dépressions sévères récalcitrante au ttt et avec pronostic sévère).

Médicaments vs psychothérapie

Des études ont montré que 75% des patients préfèrent les psychothérapies aux médicaments.

L'opposition entre ces deux modalités est fausse, les deux sont des dimensions différentes d'un même soin. Le critère principal de décision entre ces deux techniques est **la volonté du patient**.

Mais, il ne faut jamais faire de pharmacothérapie sans une dimension psychothérapeutique (peut aussi être sous forme de suivi régulier par le généraliste).

Pour les dépressions légères à moyennes, l'antidépresseur n'est pas meilleur que le placebo, car la dépression est très sensible à l'effet placebo. Il mime l'effet de l'antidépresseur (bottom-up, et non up-down), probablement par **induction sur le patient de l'effet voulu par le thérapeute**, grâce à l'explication de l'effet des traitements (ne fonctionne que si ni le patient ni le médecin ne savent pas que c'est un placebo, donc en double-aveugle), y compris les **effets secondaires**!

=> Nommer, expliquer et accompagner les effets des antidépresseurs est donc au moins aussi nécessaire que la molécule.

Avantages de la psychothérapie : Moins d'effets secondaires, moins de ruptures de traitement, effets à long terme et prévention des rechutes.

Les effets au niveau cérébral sont communs et spécifiques aux deux méthodes.

Indications au traitement combiné :

Dysthymie, et dépression chronique principalement. Egalement en cas de troubles de la personnalité, symptômes résiduels après traitement avec uniquement une des méthodes, risque de rechute...

Le traitement combiné permet en général moins de refus de traitement, une meilleure compliance médicamenteuse et un taux de réponse et de rémission supérieur.

Pour la forme saisonnière, le traitement est la **luminothérapie** uniquement.

Pour les formes légères à moyenne, la **psychothérapie** spécifique est la seule nécessaire (pas d'AD).

Pour les formes atypiques, les antidépresseurs non-tricycliques sont indiqués.

Indications à l'hospitalisation

Suicidalité incontrôlable

Épisode dépressif sévère avec inhibition ou agitation marqués

Insomnie sévère et persistante

Angoisse aiguë et attaques de panique envahissantes

Problèmes psychosociaux

Dépression réfractaire

Manie avec risque de passage à l'acte

Prise en charge par le médecin généraliste

Avantages : disponibilité à court terme, relation de confiance, pas de stigmatisation psy, suivi à long terme, etc.

Inconvénients : diagnostic parfois difficile, évitement de la confrontation au diagnostic psychiatrique (dénier de la dépression), disponibilité limitée (fréquence et durée des entretiens), stratégies pharmacologiques limitées, interprétation psychologisante (la dépression est une maladie complexe et pluri-factorielle)...

=> référer au psychiatre si :

- Diagnostic incertain
- Dépression avec symptômes psychotiques

- Dépression bipolaire
 - Dépression chronique
 - Trouble dysthymique
 - Comorbidité avec des troubles somatiques
 - Suicidalité
 - Résistance au traitement prescrit (après 4-6 semaines)
 - Intolérance aux effets IIes
 - Utilité d'une psychothérapie spécifique
-

Troubles bipolaires

Ce sont des maladies graves et chroniques. Prévalence moins importante que la dépression, mais tout de même relativement importants : 1%.

Anosognosie des épisodes maniaques en particulier.

Types de troubles

Pour définir le type de trouble, il est utile de tenir un calendrier des épisodes thymiques.

Trouble bipolaire de type 1

Diagnostic dès qu'il y a un épisode maniaque franc.

Trouble bipolaire de type 2

Au moins un épisode dépressif majeur et un épisode hypomaniaque.

Meilleur pronostic, car le pronostic dépend de l'épisode maniaque.

Trouble bipolaire avec cycles rapides

Au moins 4 cycles par année. Plus il y a de cycles, plus la maladie est grave.

NB : Le traitement anti-dépresseur doit être **stoppé** dès que l'épisode dépressif est arrêté, car son maintien accélère les cycles.

Cyclothymie

Dépression mineure et hypomanie (maniaque sans aspects psychotiques).

Il y a un continuum entre ces formes, qui ne sont pas des maladies différentes. On parle maintenant de **spectre de troubles bipolaires**.

Diagnostic

Épisode maniaque

Le début est typiquement **brutal** avec aggravation rapide.

L'intensité est variable (léger, moyen ou sévère).

Souvent, forme sévère avec **idées délirantes** ou hallucinations +/- congruentes à l'humeur.

Abus d'**alcool** ou de drogues souvent associés, qui déclenchent, aggravent et prolongent l'épisode.

=> ttt les troubles bipolaires pour réussir à ttt la toxicomanie!

La durée est variable (4-8 semaine - plusieurs mois).

80% de rémission totale si bien traité.

Problèmes diagnostiques: Les erreurs diagnostiques sont fréquentes (69% des cas), car la maladie est confondue avec : dépression, troubles anxieux, schizophrénie, trouble de la personnalité limite ou antisociale, ou abus d'alcool/de substance. Ainsi, 35% des patients attendent 10ans avant d'avoir un diagnostic correct.

Indices prédicteurs pour ce diagnostic:

Dépression débutant **avant 20ans**, accompagnée de :

- Symptômes psychotiques
- Antécédents familiaux de troubles bipolaires
- Hypomanie induite par un médicament
- Anxiété épisodique
- Irritabilité
- Dépression chronique
- Ralentissement psychomoteur

Le DD trouble bipolaire vs schizophrénie est difficile => référer au psychiatre.

On confond notamment anhédonie bipolaire et athymormie schizophrène, fuite des idées vs troubles du cours de la pensée.

Les cycles rapides se confondent avec des désorganisations émotionnelles schizophréniques.

Évolution

La durée est variable. La fréquence des cycles aussi, ainsi que l'état entre ceux-ci (rémission totale ou partielle).

La maladie est très handicapante (50% du temps symptomatique, surtout déprimé, la moitié) et létale (8-10% de suicide).

Le traitement est important : 90% de récurrence si non- traité vs 80% de rémission totale si bien traité.

Épidémiologie

Type 1 : prévalence 1% dans la population générale, H=F.

Type 2 : prévalence 2-3% (diverge selon les études car plus difficile à diagnostiquer). F>H.

Début possible à tout âge, mais souvent jeune (50% avant 20ans).

Probablement la moitié des patients pris en charge pour dépression sont bipolaires.

Le type de premier épisode (maniaque ou dépressif) est variable.

Il existe un retard diagnostic, de 10 à 15ans.

Traitement

Différentes modalités :

- Traitement des phases aiguës : EDM et phases maniaques (=> **hospitalisation d'office** souvent nécessaire, en raison des risques et de l'anosognosie, surtout dans les premiers épisodes).
- Traitement prophylactique
- Traitement non-pharmacologiques (éducation)

Phases aiguës:

Maniaques : neuroleptiques, lithium, anti-épileptiques (divalproate) et benzodiazépines.

Dépressives : Pas seulement les antidépresseurs efficaces, mais aussi le lithium, la lamotrigine et la fluoxétine (en évolution constante).

Les anti-dépresseurs ISRS sont les plus indiqués (tolérance, compliance, risque de virage maniaque améliorés).

Attention, risque de virage maniaque dans l'épisode maniaque traité aux antidépresseurs, surtout sous tricyclique (contre-indiqués). Egalement, risque d'accélération des cycles sous antidépresseurs: (25% des cas!), surtout chez femme jeunes.

Prophylaxie au long cours

En plus de traiter les phases aiguës, un thymorégulateur au long cours est nécessaire.

Stabilisateurs de l'humeur : Lithium, valproate, carbamazépine, lamotrigine, topiramate et gabapentine.

NB marge thérapeutique étroite pour le lithium => monitoring régulier, surtout au début, puis tous les trois mois. Avant le début du traitement, bilan électrolytique, cardiaque, rénal et thyroïdien.

Cave métabolisme du sel (régime sans sel, déshydratation, utilisation de diurétiques, fièvre => augmentation du taux de lithium dans le sang, qui peut être létale).

CI pendant la **grossesse**, mais celle-ci est aussi un facteur de risque de décompensation => prise en charge étroite et collaboration entre psy, gynéco et mt.

Psychoéducation

En première ligne, elle vise à améliorer la conscience de la maladie, la détection précoce des symptômes prodromaux, l'adhérence au traitement et la prévention des rechutes et du suicide.

En deuxième ligne, elle vise à gérer le stress, à éviter les abus de substances et à favoriser un style de vie le plus normal possible.

En troisième ligne, elle vise également à faire face aux conséquences psychosociales de la maladie (passées et futures), à améliorer le fonctionnement entre les épisodes et faire face aux symptômes subsyndromiques résiduels.

Troubles du spectre de la schizophrénie

Troubles psychotiques

Les troubles psychotiques (délires ou idées délirantes, troubles de perception, trouble du moi, troubles formels de la pensées) peuvent être présents dans les troubles schizo-affectifs, les psychoses, la schizophrénie, la dépression et les troubles bipolaires, et dans les addictions.

La **psychose** est définie par :

- Perte de **contact avec la réalité** : survenue de troubles de la pensée, émotionnels, perceptifs et/ou du comportement liés à une perte de contact avec la réalité.
- Selon le CIM-10 : la psychose est un terme descriptif sans référence théorique à des mécanismes psychopathologiques, utilisé pour indiquer la présence d'**hallucinations**, d'idées **délirantes**, de **désorganisation** de la pensée ou de **comportements** manifestement anormaux.

Les symptômes de la psychose sont énumérés et décrits ci-dessous.

Délire

C'est une conviction absolue mais erronée, irréductible par la logique et l'évidence des faits.

Elle n'est pas expliquée par l'appartenance à un groupe culturel et par le partage de croyances propres à ce groupe.

On peut les classer par rapport au **contenu** (de persécution, mystique, de grandeur, de référence) ou par rapport à la **cohérence** (structuré, systématisé, bizarre).

On peut concevoir le délire comme une *erreur d'interprétation* de la réalité.

Hallucinations

Perception sans objet, pouvant toucher toutes les modalités sensorielles.

Les hallucinations **auditives** sont les plus fréquentes. Très présentes dans la schizophrénie : 60-70% des patients. Elles sont alors typiquement des voix à la 3^{ème} personne, formulant des commentaires sur le comportement du patient, proférant des insultes, ou même plusieurs voix conversant entre elles.

Les hallucinations **visuelles** sont présentes chez 10% des patients.

Les hallucinations **olfactives** sont plutôt fréquentes dans l'épilepsie temporale.

Les hallucinations **cénesthésiques** sont des hallucinations de perception non-issues des organes sensoriels, par exemple sensation d'éléments dans le corps (animal dans le corps, déplacement de fluides...).

Les hallucinations **gustatives** sont aussi possibles.

Troubles du moi

Troubles de l'éprouvé de l'autre ou de l'environnement, du vécu d'unité du moi ou de l'apparence du moi. Sentiment d'être une "poupée", sans avoir le contrôle.

- **Dépersonnalisation** (sentiment d'être irréel, transformé) et **déréalisation** (personnes et objets semblent irréels)
- **Devinement** de la pensée (les pensées n'appartiennent plus au patient lui-même, d'autres y participent et savent ce qu'il pense) ou **vol de la pensée** (pensées sont enlevées ou prélevées)
- Pensées **imposées** (pensées sont vécues comme influencées, fabriquées, dirigées ou gouvernées)

Troubles formels du cours de la pensée

Se manifestent dans le langage et traduisent un flux ou une organisation déficiente de la pensée. Notamment :

- Pensée **ralentie**
- Pensée **circonscrite** (ne distingue pas l'essentiel de l'accessoire => parle des heures) ou au contraire **fuitedes idées** : afflux d'idées qui ne sont pas dirigées par un projet. Le but de la pensée est en changement permanent.
- Réponses **à côté** : réponses incongrues même à des questions simples, **néologismes**, pensée **incohérente**.

Toutes ces dimensions ne sont pas présentes chez tous les patients.

Formes principales des troubles psychotiques

Classification

1. De cause somatique (toxique, infectieuse, encéphalite...)
2. Non associé avec un épisode thymique (= **psychoses non-affectives**)
 - a. Avec un facteur déclenchant et d'apparition subite: *Trouble psychotique aigu et transitoire, psychose du post partum, folie à deux*
 - b. Sans facteur déclenchant, d'apparition progressive
 - i. Seulement délirant : *trouble délirant persistant*
 - ii. Avec tous les symptômes de la psychose: *schizophrénie*
3. Associé avec un épisode thymique :
 - a. Disparition avec la résolution de l'épisode thymique (= **psychoses affectives**) : *épisode maniaque avec symptômes psychotiques, EDM avec symptômes psychotiques*
 - b. Persistant au-delà de la résolution de l'épisode thymique : *trouble schizo-affectif*

Trouble schizo-affectif

Il est à l'interface entre les psychoses affectives et non-affectives.

Définition: Trouble **épisodique** marqué par :

1. La présence conjointe de symptômes **affectifs** (manie ou dépression, ou les deux) et symptômes **psychotiques**
2. La persistance des symptômes psychotiques au-delà de **2 semaines après la résolution** de l'épisode affectif.

Psychoses non-affectives

On les différencie en fonction de la présence d'un facteur déclenchant récent ou d'une apparition progressive.

S'il y a un facteur déclenchant et une apparition subite, il peut s'agir de **trouble psychotique aigu et transitoire**, de **folie à deux** ou de **psychose post-partum**.

Parmi les progressifs, s'il n'y a que des symptômes délirants (sans autres symptômes de psychose), on parle de **trouble délirant persistant**, sinon, il s'agit de **schizophrénie**.

Troubles psychotiques aigus et transitoires

C'est un trouble psychotique d'**apparition aiguë** (en 2 semaines ou moins), en présence d'un **facteur de stress aigu** (accident, décès subit, deuil, perte d'emploi, mariage...).

On distingue deux formes selon le types de symptômes psychotiques présents et leur fluctuations :

1. *polymorphe* : symptomatologie changeant rapidement au cours de la journée. Hallucinations, idées délirantes et perturbation des perceptions très variables d'une heure à l'autre. Fréquemment, présence de bouleversement émotionnel, avec passages d'extase à irritabilité et anxiété.
2. *d'allure schizophrénique* : moins de variation au cours de la journée, symptômes schizophréniques importants : troubles du moi, bizarreries, écho de la pensée, hallucinations auditives de voix commentant le comportement, etc.

Plus l'apparition est aiguë, meilleur est le pronostic.

La forme polymorphe apparaît souvent brutalement et disparaît également rapidement. Si elle persiste plus de trois mois, revoir si le diagnostic n'est pas plutôt celui d'un trouble délirant persistant. La forme d'allure schizophrénique se résout normalement rapidement. Si elle persiste au-delà d'un mois, il s'agit de schizophrénie et non d'un trouble transitoire.

Trouble délirant induit ou folie à deux

C'est un trouble délirant rare, partagé par deux ou un groupe de personnes. **Une seule** personne présente un authentique trouble psychotique, et les idées délirantes induites disparaissent en cas de séparation. Les thèmes habituels sont des thèmes de **persécution** ou de **grandeur** (mystique aussi). Dans la plupart des cas, ils sont liés à l'établissement d'une **relation d'une intensité** inhabituelle (week-end de réflexion sur un sujet particulier, lien social, linguistique...).

Les hallucinations sont extrêmement rares.

Le diagnostic peut se faire par la présence d'éléments suivant :

- Deux ou plusieurs personnes partagent la même idée délirante
- Il existe une relation très étroite entre ces personnes
- On met en évidence des arguments chronologiques montrant l'induction du délire chez l'un par l'autre.

Psychose du post-partum

Manifestation : Apparition rapide, chez des femmes habituellement **sans antécédent psychiatrique**, dans les **6 à 48h** après l'accouchement de

- Euphorie, hyperactivité, fuite des idées, hypersociabilité, troubles du sommeil
- Délire (mégalo-maniaque ou paranoïde) à son propre sujet ou à celui de l'enfant
- Possibilité d'éléments dépressifs également

L'évolution sans traitement est incertaine, et peut durer **plusieurs mois**. Représente donc un risque majeur pour l'enfant, et nécessite une prise en charge immédiate avec des **médicaments** (anti-psychotiques ou stabilisateurs de l'humeur) et une **hospitalisation** de la mère avec son bébé.

Trouble délirant persistant

C'est un trouble sans symptômes thymiques, d'apparition progressive et sans facteur déclenchant apparent, **uniquement délirant** sans autres symptômes psychotiques.

Le délire est souvent **systématisé** (habituellement paranoïde ou de grandeur).

Traitement : Faible réponse au traitement neuroleptique.

NB, la terminologie française le caractérise de délire paranoïaque chronique.

Schizophrénies

Le terme schizophrénie s'applique à un groupe hétérogène de troubles, qui ont en commun un certain nombre de symptômes, présents pendant **plus d'un mois** :

- symptômes **psychotiques** (positifs) dans les phases aiguës
- symptômes **négatifs**

- troubles **cognitifs**

La première description est de E Bleuler (1908), et repose sur un modèle de symptômes **primaires**, issus d'un processus pathologique (organique?), compliqués périodiquement de symptômes **secondaires**, issus de la réaction du psychisme au trouble primaire.

Les symptômes primaires sont présents chez tous les patients. Les symptômes secondaires sont moins spécifiques, et pas toujours présents.

En 1982, les symptômes ont été reclassés en symptômes **positifs** et **négatifs** (perte).

- Symptômes positifs : hallucinations, délire, trouble de la pensée formelle, comportement désorganisé
- Symptômes négatifs : affect aplati, alogie (perte de faculté de parler), anhédonie et retrait social, apathie

Symptômes positifs

Les symptômes positifs ne sont pas pathognomiques de la schizophrénie, et plus typiques de la phase aiguë. Ils répondent assez bien aux antipsychotiques (potentiellement liés à une hyperactivité dopaminergique de la voie méso-limbique).

Symptômes négatifs

Les symptômes négatifs sont associés à un état déficitaire, un mauvais fonctionnement prémorbide et un mauvais pronostic.

Ils sont relativement stables et peu ou pas réversibles, difficiles à différencier des symptômes dépressifs et résistants aux anti-psychotiques. Potentiellement liés à une hypoactivité de la voie dopaminergique (atteinte du lobe frontal?).

Troubles cognitifs

Ils sont présents chez 60-80% des patients, et aussi présents chez les proches de 1^{er} degré (atténués), et déjà présents dans la phase prodromique. Ils déterminent en partie le pronostic et la réhabilitation. Les déficits les plus fréquents touchent : l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives et la "cognition sociale".

Formes cliniques de schizophrénie (désuètes) :

- **Paranoïde** : la plus fréquente. Les symptômes positifs dominent.
- **Hébéphrénique** : apparition précoce (puberté). La désorganisation de la pensée prédomine, avec une perturbation des affects et du comportement. Les symptômes négatifs apparaissent précocément.
- **Catatonique** : plus rare actuellement. Les comportements physiques prédominent : stupeur, posture catatonique, négativisme, rigidité, flexibilité cireuse.
- **Indifférenciée**
- **Résiduelle** : symptômes positifs atténués et symptômes négatifs.

Définition CIM-10

Symptômes caractéristiques : ≥ 1 critère (1 à 4) ou ≥ 2 critères (5 à 8), pendant ≥ 1 mois, ou critère (9) pendant ≥ 12 mois (soit 1 an pour la schizophrénie simple), sans faire référence à une phase prodromique non psychotique :

1. Écho de la **pensée**, pensées imposées ou vol de la pensée, divulgation de la pensée.
2. Idées **délirantes** de contrôle, d'influence ou de passivité, se rapportant clairement à des mouvements corporels ou à des pensées, actions ou sensations spécifiques, ou perception délirante.

3. **Hallucinations** auditives dans lesquelles une ou plusieurs voix commentent en permanence le comportement du patient, ou parlent de lui ou autres types d'hallucinations auditives dans lesquelles une ou plusieurs voix émanent d'une partie du corps.
4. Autres idées délirantes persistantes, culturellement inadéquates ou invraisemblables, concernant p. ex. l'identité religieuse ou politique ou des pouvoirs surhumains (être capable de contrôler le temps, ou de communiquer avec des extraterrestres...).
5. Hallucinations persistantes de n'importe quel type, accompagnées soit d'idées délirantes fugaces ou à peine ébauchées, sans contenu affectif évident, soit d'idées surinvesties persistantes, ou hallucinations survenant quotidiennement pendant des semaines ou des mois d'affilée.
6. Interruptions ou altération par interpolations du **cours de la pensée**, rendant le discours incohérent et hors de propos, ou néologismes.
7. Comportement **catatonique** : excitation, posture catatonique, flexibilité cireuse, négativisme, mutisme ou stupeur.
8. Symptômes "**négatifs**" : apathie importante, pauvreté du discours, émoussement affectif ou réponses affectives inadéquates (ces symptômes sont généralement responsables d'un retrait social et d'une altération des performances sociales). Il doit être clairement établi que ces symptômes ne sont pas dus à une dépression ou à un traitement neuroleptique.
9. Modification globale, persistante et significative de certains aspects du comportement, se manifestant par une perte d'intérêt, un comportement sans but, une inactivité, une attitude centrée sur soi-même, et un retrait social.

Critères d'exclusion :

1. Symptômes **dépressifs** ou **maniaques** au premier plan, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles de l'humeur. Ou symptômes affectifs d'importance à peu près égale aux symptômes schizophréniques et se développant simultanément : trouble schizo-affectif
2. Atteinte **cérébrale** manifeste ou apparaissant au cours d'une épilepsie
3. **Intoxication** ou un sevrage à une substance psycho-active

Épidémiologie et étiopathogénie

La schizophrénie touche environ **1%** de la population mondiale. Le risque augmente avec l'environnement urbain.

Elle commence entre 18 et 25ans chez les hommes, et entre 24-35ans chez les femmes (avec un deuxième pic après la ménopause).

L'espérance de vie est 20% inférieure à la population générale (suicide, maladies respiratoires et infectieuses, abus de substances et maladies cardiovasculaires) => hypothèse de bases génétiques communes (phénomènes inflammatoires?) .

Évolution à long terme : **25% de guérison**, 25% de récives et 50% d'évolution chronique avec aggravation.

Étiologies

La schizophrénie n'est pas liée à un seul facteur, mais à l'interaction de divers facteurs intrinsèques et extrinsèques. Des facteurs de risque prémorbides donnent une vulnérabilité, qui peuvent faire basculer dans la psychose s'il y a des facteurs de stress (plus ou moins importants).

Facteurs de vulnérabilité :

- Biologiques : **génétique** (50% entre vrais jumeaux), lésions **cérébrales** (sur maladie ou trauma), complications **obstétricales** pré- ou péri-natales (notamment infection virale de la mère pendant le

premier trimestre ou anoxie cérébrale à la naissance => anomalies du développement cérébral), déficit en **glutathion** (facteur de risque pour la lésion progressive des neurones par oxydation), neurotransmetteurs (surtout montrés par l'efficacité des bloqueurs dopaminergiques, mais pas de preuve réelle. Hypothèse d'interaction entre sérotonine, glutamate et système dopaminergique).

- Psychologiques et environnementaux: **trauma** psychologique/sexuel, **migration**, **THC** (risque x 2-4 si avant 14ans, n'augmente pas le risque plus tard, mais augmente le nombre d'épisode si déjà schizophrénie), urbanité, troubles de l'**apprentissage**, mauvais traitement entre dans la petite enfance...

Comorbidités

Les patients atteints de schizophrénie présentent fréquemment des pathologies associées : dépression, abus de substances (30-50% chez les patients jeunes), TOC et anxiété.

Traitement

Nécessite une prise en charge **globale** avec un ensemble d'éléments, médicamenteux, sociaux et psychothérapeutiques. L'objectif actuel est de faire un maximum en ambulatoire et de limiter les hospitalisations les plus brèves possibles.

Intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques

Contexte et concepts

But : intervenir plus tôt (jusque là, environ 2ans avant un diagnostic).

Il y a une **période critique** dans les 2-3 premières années de maladie pendant laquelle plusieurs déficits s'installent, en particulier cognitifs (qui tendent ensuite à se stabiliser).

Comme plusieurs diagnostics peuvent être à l'origine de psychose et que le DD n'est pas facile, on a mis en place des programmes de dépistages et de traitement des **psychoses** (et non des schizophrénies). Le concept de **staging clinique** permet de déterminer les besoins en fonction du stade de la maladie.

Phases cliniques

La phase **prémorbide** peut être utile à surveiller (chez enfants de patients par exemple).

Le début de la maladie commence à l'apparition de **prodromes**, qui précèdent les premiers **épisodes psychotiques**. Les prodromes sont les premiers pas d'installation des symptômes négatifs, qui augmentent de plus en plus et sont non-modifiés par les traitements. Entre ces épisodes et le début du traitement, on parle de **DUP** (durée de psychose non-traitée). Le premier traitement permet une **rémission dans une partie des cas**, d'autant plus s'il est instauré précocement. Les symptômes négatifs sont ceux qui mènent au handicap fonctionnel, et qui bénéficient le plus d'une intervention précoce.

Les objectifs sont donc :

- diminuer le délai entre l'apparition des symptômes de la maladie et le début du traitement :
 - Sujets à risque: intervention dans la phase des prodromes
 - Premier épisode psychotique: diminution de la DUP
- adapter le traitement à ce stade particulier de la maladie

Intervention dans la phase prodromique

Certains critères permettent d'identifier les patients qui risquent de développer une psychose. L'intervention précoce (psychothérapie et/ou neuroleptiques atypiques, ou "neuro-protection" par

acides gras Ω -3) a montré une **diminution de l'émergence** de ces psychoses, mais, malgré une assez bonne sensibilité, la spécificité n'est pas excellente => problèmes éthiques : on ne peut pas autoriser l'instauration d'un traitement sur la *suspicion d'un risque* de psychose.

Intervention lors d'un premier épisode psychotique

Impact de la longueur du DUP : les tentatives de suicides sont relativement fréquentes dans les premières phases de la maladie (avant le diagnostic). Les abus de substance commencent également souvent dans la première phase, et elle a des impacts socio-économiques importants (rupture du parcours scolaire, perte d'emploi...). La détresse est importante.

La réponse au traitement dépend aussi de la longueur du DUP ainsi que la qualité de vie.

Pour optimiser la prise en charge précoce (ce sont souvent des patients jeunes) :

- Formation des médecins de premiers recours
- Information du public (but : interventions dans les écoles)
- Meilleure détection des symptômes précoces, qui sont peu typiques :
 - Dépression, anxiété, repli sur soi, irritabilité, suspicion, baisse de rendement scolaire observé par les proches
 - Changement d'humeur, manque de motivation, troubles du sommeil, difficultés de concentration, pensées ralenties, sentiment d'irréalité, d'étrangeté, modification de perception de l'entourage ressentis par le patient

=> Ces deux éléments, en présence de facteurs de risque (adolescent ou jeune adulte, antécédent familial, complication obstétricales ou retard de développement, évènement déclencheur, abus de substance) doivent faire suspecter un trouble psychotique => évaluation spécialisée.

Le DUP *après* le diagnostic est également présent. Il faut donc renforcer l'accessibilité des soins, adapter le traitement et l'amélioration de l'adhérence au traitement et faire un travail spécifique d'**engagement du patient dans les soins** : optimisme, soins ambitieux orientés vers le rétablissement, partenariat, flexibilité.

Programme TIPP (traitement et intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques)

La famille, les généralistes, les psychiatres et les institutions psy peuvent demander une première évaluation par téléphone, qui aboutit si possible sur une évaluation clinique.

Pour les patients qui ont une difficulté à adhérer aux soins ou même à y entrer, les **SIM**, ou **suivi intensif dans le milieu** ont été développés (=> intervention des case managers infirmiers et travailleurs sociaux hors de l'hôpital), qui permettent l'entrée dans le système de soin, l'évaluation dans le milieu, et une alternative à l'hospitalisation.

Les patients sont normalement suivis pendant **trois ans** par un psychiatre et un **case manager** (qui est supervisé une fois par semaine). Si nécessaire, une hospitalisation peut avoir lieu.

Les SIM permettent également le suivi prolongé, après ces trois ans.

Des outils pédagogiques ont également été développés (application iphone informative, manuels pour les professionnels, etc.)

Traitement spécifique de la psychose émergente : Règles de base pour la médication

- Observation 24 – 48h avec benzodiazépines (si possible)
- Utilisation de **faibles doses** de neuroleptiques
- Favoriser les neuroleptiques **atypiques** :
 - Limitation des effets secondaires extrapyramidaux

- Instaurer un suivi des effets secondaires métaboliques : Suivi rapproché au début (1 mois, 2 mois, 3mois) du profil lipidique, BMI, tour de taille. Les patients prenant beaucoup de poids au début sont à risque d'en prendre beaucoup ensuite.
- Suivre la réponse et adapter le traitement si absence de réponse

Après 4 semaines, les symptômes doivent avoir diminué. Sinon, il faut adapter les doses.

Stratégies d'engagement

Parler des problèmes concrets, essayer de trouver des solutions => s'adapter au degré de lecture que le patient a de sa pathologie.

Redonner l'espoir et les vrais chiffres sur les chances de guérison.

Prendre le temps de comprendre la personne dans son entier et non pas seulement ses symptômes, et son explication de la maladie (ou de ce qu'il ne considère pas comme une maladie).

Parler des ressources du patients, et pas seulement de ses problèmes : être optimiste!

Etre prêt à faire face à des ruptures qui peuvent aussi permettre des expériences et à terme renforcer l'alliance. L'engagement est un processus progressif : être persévérant.

Se laisser **toucher** par l'histoire du patient!

Raisons du désengagement des soins (28% dans les **premiers mois** des soins)

Facteurs prédictifs :

- Passé judiciaire (association entre psychiatrie et institution autoritaire)
 - Symptômes peu marqués à l'entrée (=> banalisation par les soignants)
 - Absence de liens avec la famille
 - Persistance d'abus de substance
- => interventions de groupes familiaux, séances d'informations pour la famille, etc.

Des études ont montré l'efficacité de ces modèles de soins, qui sont plus **efficaces** et plus **économiques**.

Conclusions :

1. La prise en charge de la phase précoce des troubles psychotiques nécessite une adaptation du traitement :
 - a. Modifications de l'organisation des services
 - b. Modifications du contenu des soins
 - c. Modifications de l'état d'esprit dans lequel les soins sont prodigués
2. Une meilleure connaissances des mécanismes neurobiologiques impliqués dans cette phases permettrait:
 - b. D'améliorer nos capacités de diagnostic précoce
 - c. De développer des approches thérapeutiques mieux ciblées
 - d. D'affiner le modèle de staging clinique
3. Considérant l'impact potentiel des troubles psychotiques, il est urgent d'adapter l'organisation des soins aux besoins de ces patients et d'intensifier la recherche dans ce domaine
4. Des démarches similaires devraient être développées pour les autres formes de pathologie psychiatrique

Témoignage de patient

Homme, 45ans. Trois épisodes de psychose avec hospitalisation (suite à des grosses bagarres). Télépathie, vol de pensée, difficulté d'endormissement, impression que tout ce qui est écrit dans le journal "est de notre faute". "tout va à 100 à l'heure, on n'a pas envie de dormir pour profiter de cet effet". Accompagné d'une certaine agressivité.

La crise est agréable, mais la chute est pire (en raison de ses conséquences). Regrets.

L'entourage "ne comprenait pas". L'impression d'avoir raison, et pas envie de se faire soigner, "jusqu'à ce que ça explose". Délire de persécution lors de l'hospitalisation (enfermement ferme). "A l'époque, c'était comme une prison".

Télépathie considérée comme un don difficile à gérer. Croyant, pense que la croyance l'aide à se reposer sur quelque chose, à prier quand il ne va pas bien.

Difficultés majeures : regard des autres. "Ceux qui ramassent le plus, c'est l'entourage".

Cannabis dès 14ans, encore aujourd'hui (mais moins), mais stoppe pendant les psychoses.

Notion de toutes les souffrances de l'enfance qui "sortent à l'adolescence". Divorce des parents.

"j'en guérirai jamais, j'pourrai soigner mais j'en guérirai jamais".

Les rechutes ont toujours été liées à la non-prise de médicaments.

Médicaments : effets IIres de bave la nuit, et doit aller se coucher après (sinon s'endormirait n'importe où).

Les rechutes sont plus fréquentes en hiver.

Consultation tous les deux mois en période stable, de manière plus rapprochée autour des crises.

Danger pour lui-même pendant la crise : s'est jeté sous un camion par besoin de "choc" pour arrêter un délire d'enfermement dans une boîte de plus en plus petite et brûlante. On aurait cru à un suicide s'il était mort, mais ce n'était pas une volonté de mourir, uniquement de réussir à sortir de cette situation oppressante. C'est "la voix" qui lui a dit de sauter devant le camion "je ne sais pas comment j'aurais fait si elle ne me l'avait pas dit pour m'en sortir".

Meilleur moyen d'aider pendant la crise : le laisser tout seul. Ne se rend compte qu'après-coup que c'était anormal. Pour réaliser qu'il a une rechute, il nécessite l'intervention de ses amis.

Il y a de temps en temps la voix qui dit des choses. "le bon Dieu ou le Diable, je ne sais pas".

Pas réellement de désir suicidaire, même en état de psychose.

N'a pas peur de mourir, croit en la suite. Dans ses états de psychose, communique avec ses amis morts.

Consulter le psychiatre pendant la crise l'aide. En-dehors des crises, "on n'a pas grand-chose à se dire". Il ne le convainc pas que l'idée est fausse, mais écoute et entend les idées délirantes.

"on est tous un peu fous"

Diagnostic

Crises maniaques avec symptômes psychotiques persistant au-delà des épisodes maniaques => **trouble schizo-affectif.**

Il a un bon insight sur la maladie, mais il voit la maladie comme une exagération de ce qui est réellement. Il ne sert à rien d'essayer de convaincre la personne que rien n'est réel.

Les patients considérant entièrement que ce n'est que de la maladie ont plus souvent tendance à devenir dépressifs.

Troubles anxieux

Introduction

L'anxiété est normale à un certain niveau, (situations de stress de la vie courante), peut être secondaire à certaines pathologies organiques, fait aussi partie de certains autres troubles psychiatriques (dépression et schizophrénie), ou peut faire partie de **troubles anxieux spécifiques**.

L'anxiété est non pathologique si:

- La souffrance est faible et **supportable**, avec un sentiment de contrôle du vécu psychopathologique (capacité de mettre de côté les symptômes temporairement si nécessaire)
- L'interférence est minime avec la vie quotidienne
- Liée à un évènement que l'on peut considérer comme angoissant pour la majorité des sujets
- Associée à **peu** de symptômes physiques
- La **durée** est limitée

Déprimé ou angoissé ?

Les deux états partagent des symptômes communs :

- Fatigue, manque d'énergie, baisse de l'élan vital
- Troubles de la concentration
- Troubles du sommeil
- Troubles de l'appétit
- Plaintes somatiques cardiovasculaires ou digestives
- Irritabilité
- Idéation suicidaire

La distinction entre les deux est assez fine, et fonction de l'état d'esprit.

Dans la dépression le patient vit dans l'effet d'une **perte réalisée**, tournée vers le **passé**, alors que dans l'anxiété, le patient est dans une **anticipation** anxieuse (crainte d'un malheur **futur**).

La patient dépressif est **ralenti** (dévitalisé, dépossédé de sens), avec un **repli** sur soi, le patient anxieux est **inhibé** (sidéré), avec des comportements d'**évitement**.

Dépression sentiment de **désespoir**, vs anxieux : **dépersonnalisation** (non familiarité) et **déréalisation** (coupé de la réalité).

Somatisations : **Douleurs chroniques** chez les dépressifs, vs troubles **neuro-végétatifs** (panique) avec les troubles anxieux.

“Trouble anxio-dépressif” n'est pas un diagnostic. L'anxiété peut être une composante importante dans la dépression, et les troubles anxieux évoluent souvent vers des dépressions, mais par contre, rarement l'inverse (la dépression évolue rarement en troubles anxieux).

On parle alors de trouble anxieux compliqué d'un épisode dépressif. Il faut déterminer le trouble principal, car le traitement en dépendra.

S'il y a une comorbidité réelle entre ces deux états, c'est un facteur aggravant (sévérité du tableau, suicide, chronicité, autres comorbidités, réponses thérapeutiques...).

Épidémiologie

Fourchette large car diagnostic difficile.

Proportion importante de la population, total des troubles anxieux; environ **15-20%**.

Nosologie des troubles anxieux

Les troubles anxieux sont toujours **connus** des patients. Ils reconnaissent la dimension exagérée de l'anxiété face au déclencheur, ce qui rend l'alliance thérapeutique plus aisée que dans les troubles de l'humeur.

Attaque de panique

L'attaque de panique est l'épisode aigu qui compose les troubles paniques (comme les épisodes thymiques composent les troubles de l'humeur).

Se traduit souvent principalement par des symptômes **somatiques**. 90% des patients consultent pour les symptômes somatiques (cardiaques, neurologiques, GI, pulmonaires).

Symptômes psychiques (paroxystiques)

- Sensation de malaise ou de peur intense : Peur de s'évanouir, de mourir, de perdre le contrôle (pensée ou comportement), de devenir fou, de ne pas pouvoir être secouru.
- Dépersonnalisation
- Déréalisation (peut être décrit comme une diplopie)

Symptômes psychomoteurs

Activation psychomotrice avec agitation, crispation, crise clastique, ou au contraire, inhibition (sidération stuporeuse).

Symptômes somatiques

Liés à l'activation neuro-végétative. Les plus fréquents sont cardiaques, gastro-intestinaux et pulmonaires.

- Palpitations, tachycardie
- Gène ou douleur thoracique
- Dyspnée, étouffement, étranglement
- Tête vide, instabilité, vertige
- Tremblement et secousses musculaires
- Frissons et bouffées de chaleur
- Sudation profuse
- Nausée ou gène abdominale
- Paresthésie

Les attaques de paniques sont fréquentes dans d'autres maladies psychiatriques, en particulier la dépression, l'agoraphobie et la dépendance OH.

Elles peuvent être inattendues, favorisées par une situation particulière ou induites.

Trouble panique

Maladie composée d'un ensemble d'attaques de paniques.

Débute souvent avec une première attaque sans facteur déclenchant.

DSM-IV :

1. Attaques de paniques **récurrentes et inattendues**
2. Au moins un des symptômes parmi :
 - a. **Crainte** persistante d'avoir des attaques de paniques

- b. Préoccupation à propos des **implications** possibles de l'attaque ou de ses conséquences (perdre de le contrôle, avoir une crise cardiaque, "devenir fou")
- c. Changement de **comportements** importants en relation avec les attaques (conduites d'évitement)

Progression "classique" des symptômes, en phases:

1. Attaques spontanées
2. Sensibilisation
3. Trouble panique
4. Évitement menant à l'agoraphobie
5. Démoralisation menant à la dépression
6. Développement de dépendances

Ainsi, un tiers des patients développent une agoraphobie, jusqu'à deux tiers une dépression, et 20% se suicident.

Un **tiers** des patients guérissent. La moitié ont un trouble récurrent chronique mais peu grave. Le reste développe un trouble chronique sévère (environ 18%).

En moyenne, 12.7 consultations aux urgences avant de recevoir le diagnostic.

Épidémiologie : 2x plus de femmes que d'hommes. Prévalence sur la vie entière entre 1 et 4%.

Traitement : benzodiazépine, +/- anti-dépresseurs SSRI +/- psychothérapie. Réagit bien aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (SSRI).

Agoraphobie

Peut exister seule ou être la complication de troubles paniques.

C'est une anxiété liée au fait de se retrouver dans des endroits ou situations d'où il pourrait être difficile de s'échapper ou dans lesquels on ne pourrait pas trouver de secours en cas de symptômes de type panique. Ex: seul en dehors du domicile, dans une foule ou une file d'attente, sur un pont, dans un autobus, un train ou une voiture.

Réagit mal aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. TTT: psychothérapie spécifique.

Phobies spécifiques

Conduisent à l'attaque de panique uniquement si la confrontation à l'objet déclencheur est inévitable et persistante.

Le sujet en reconnaît le caractère excessif et irraisonné.

Classification DSM des "peurs phobiques" : animal, environnement naturel, sang-injection-accident, situationnel ou autre.

C'est un trouble mineur.

Phobie sociale

Définition : peur persistante et intense d'une ou plusieurs situations sociales ou de situations de performance, durant lesquelles le sujet est en contact avec des gens non-familiers ou potentiellement exposé à l'observation attentive d'autrui. Le sujet craint d'agir ou de montrer des signes d'anxiété de façon embarrassante ou humiliante.

L'exposition à la situation sociale redoutée provoque de façon quasi systématique une anxiété.

Le sujet en reconnaît le caractère excessif et irraisonné.

Les personnes réellement atteintes sont rares, il y a à nouveau eu une médiatisation maximale pour la vente du traitement, qui a causé un surdiagnostic.

DD agoraphobie : en cas d'agoraphobie, le sujet ne sort jamais seul, fait ses achats dans des petits commerces, s'assied proche de la sortie dans un restaurant et n'a pas d'érythrophobie (peur de rougir). En cas de phobie sociale par contre, le sujet sort presque toujours seul, peut faire ses achats dans des supermarchés, préfère dans les restaurants les coins les plus reculés, et a fréquemment une érythrophobie.

Traitement : psychothérapie spécifique, benzo, SSRI.

Trouble obsessionnel-compulsif

Mélange de deux manifestations :

1. Psychiques : **Obsessions** (pensées et images persistantes), de différents types : idéatives (doutes), impulsives (peur d'impulsions, d'actes ou de paroles transgressifs), phobiques. Pour être considérées comme des troubles, elles entraînent une anxiété ou une **détresse importante**. Comme les troubles anxieux, le sujet reconnaît qu'elles proviennent de sa propre activité mentale.
2. Comportementaux : **Compulsions** (comportements répétitifs ou actes mentaux) destinés à neutraliser ou à diminuer un sentiment de détresse ou à empêcher une situation redoutée.

Catégories du TOC : lavage (la compulsion diminue l'obsession), vérifications (la compulsion a peu d'effet sur l'obsession), ruminations (phobies d'impulsion), syndrome de lenteur primaire (actes courants accomplis dans un ordre précis).

Difficile à traiter. TTT : psychothérapie spécifique (TCC) et SSRI.

DD :

- Schizophrénie stabilisée
- Affections neurologiques
- Dépression majeure

Anxiété généralisée

Plus difficile à diagnostiquer.

Il s'agit de préoccupation incontrôlable relative à des événements négatifs mais **réalistes** de la vie quotidienne, dont le **risque** de survenue est **surestimé**.

Présence de symptômes neuro-végétatifs ou fonctionnels chroniques (céphalées, troubles digestifs, troubles du sommeil, douleurs musculaires).

DSM - IV:

1. Anxiété et soucis excessifs la plupart du temps au moins pendant 6mois, concernant un certain nombre d'évènements ou d'activités (travail, école..)
2. Difficulté à contrôler cette préoccupation
3. Au moins trois des six symptômes suivants :
 - a. Agitation ou sensation d'être survolté ou à bout
 - b. Fatigabilité
 - c. Difficulté de concentration, trous de mémoire
 - d. Irritabilité
 - e. Tension musculaire
 - f. Perturbation du sommeil

Les patients atteints étant des grands consommateurs de soins, on va souvent en voir. Seul un tiers des patients en reçoivent le diagnostic correct.

La majorité des patients se plaignent de symptômes somatiques.

Les spécialistes les plus consultés sont les gastro-entérologues (côlon irritable).

Traitement : psychothérapie spécifique, +/- SSRI.

Troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse

Il s'agit du développement de symptômes anxieux en *réaction* à un ou plusieurs facteurs de stress identifiables, trois mois suivant leur survenue, cliniquement significatif car provoquent soit une souffrance marquée soit une altération significative du fonctionnement (social ou professionnel). Même définition que le trouble de l'adaptation dépressif, distinction clinique peu claire.

Traitements

Médicaments

Pas en cas de phobies simples.

Anti-dépresseurs : SSRI, IMAO réversibles et tricycliques.

Benzo: forte dose au début, puis stop (en réserve : risque de dépendance).

Anxiolytiques non-benzo (buspirone)

Neuroleptiques

B-bloquants

TCC

Indiquée pour tous les troubles anxieux.

Psychanalyse

Pas indiquée pour les TOC ni l'état de stress post-traumatique, mais indiquée pour les autres troubles anxieux.

Etats de stress et réactions post-traumatiques

Fréquent et à détecter, car peut se chroniciser et devenir handicapant.

Facteur déclenchant : **traumatisme psychique**, qui se définit par :

- Une confrontation directe avec la **mort** (ou un risque de mort)
- Une **menace** par rapport à l'intégrité psychique et physique
- Un caractère **soudain** et **intense**
- Un vécu d'**impuissance** et de **contrainte**

Les facteurs traumatiques sont les caractéristiques de l'évènement, le sens que prend cet évènement pour la personne, le contexte de l'évènement, et la vulnérabilité de la personne au moment de l'évènement.

Etat de stress **aigu**

Les réactions de protection immédiate sont le **stress** (physique et psychologique) et la **dissociation** (déconnection d'une partie de soi-même lorsque la situation est trop intense => torpeur,

détachement, absence de réactivité, réduction de la conscience de l'environnement, déréalisation, dépersonnalisation, amnésie).

Définition de l'état de stress aigu

Le sujet a été exposé à un événement traumatique, dans lequel :

1. Le sujet a vécu, été témoin ou été confronté à un/des événement(s) durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés, ou ont été menacé de mort ou de grave blessure, ou l'intégrité physique ou celle d'autrui a été menacée
2. La réaction du sujet s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur

Autres symptômes : Remémoration, évitement des stimuli qui réveillent la mémoire, symptômes **anxieux** ou activation neuro-végétative.

État de stress **post-traumatique**

Il peut y avoir un temps de latence prolongé après cet état de stress aigu avant l'apparition d'un état de stress post-traumatique, qui apparaît dans 11% des cas (F>H).

Les formes subsyndromiques sont fréquentes.

Prévalence sur la vie : 1-2% en EU, 8% aux US.

Il se manifeste par un syndrome de **remémoration** et un syndrome d'**évitement**.

Remémoration:

- Souvenirs répétitifs et envahissants de l'évènement
- Rêves répétitifs
- Impression soudaine que l'évènement va se reproduire
- Détresse psychique lors de l'exposition à des indices évoquant l'évènement
- Réactivité physiologique dans des situations analogues

Évitement :

- Effort pour éviter les pensées, sentiments et conversations associées au traumatisme
- Effort pour éviter les activités, endroits ou gens éveillant le souvenir
- Incapacité à se souvenir d'un aspect important du traumatisme
- Réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes
- Sentiment de détachement d'autrui, de devenir étranger aux autres
- Restriction des affects
- Sentiment d'avenir bouché

De plus, une activation **neurovégétative** accompagne ces syndromes et entraîne troubles du sommeil, irritabilité, difficultés de concentration, hypervigilance et sursauts exagérés.

Pour éviter l'apparition de ces symptômes, deux prises en charge :

- Immédiatement : **defusing** (dans les heures qui suivent). Tranquilliser, exprimer le vécu immédiat, évaluer le besoin de soutien, mais pas de réexposition.
- Dans les jours qui suivent : **debriefing**. Permettre aux personnes présentes en même temps de se revoir, remettre les événements dans leur chronologie, laisser la place au vécu, informer sur les réactions possibles, etc.

Pour le traitement de suivi, on peut utiliser la TCC, les EMDR et éventuellement les SSRI.

! Ne pas donner des benzodiazépines. Induisent des réactions de stress paradoxal.

Troubles de la personnalité

Tempérament, caractère et personnalité

Les troubles de la personnalité sont des définitions à prendre avec prudence.

Tempéraments et traits de personnalité étaient déjà décrits avec les théories de l'humeur.

Définitions actuelles :

- **Tempérament** : fondements biologiques du caractère, disposition générale de l'humeur et de la sensibilité du sujet.
- **Caractère** : partie psychologique du fonctionnement, construite par l'histoire personnelle.
- **Personnalité** : résulte de ce que l'individu fait de son tempérament et de son caractère.

“Le tempérament d'un individu, c'est ce que la nature a fait de lui; son caractère, c'est que l'histoire a fait de son tempérament; et sa personnalité, c'est ce qu'il a fait, et ne cesse de faire, de ce que la nature et l'histoire ont fait de lui.”

Nosologie

Dans le DSM-IV, les troubles de la personnalité étaient différenciés des troubles spécifiques (de l'humeur, psychose...) et des maladies somatiques, en un système **multiaxial**. Cette différence a disparu dans le DSM-V.

Le système catégoriel a des limites, on ne peut pas mettre quelque chose d'aussi complexe que la personnalité dans des boîtes. Il permet cependant de déceler des personnes avec des troubles importants.

Définition générale des troubles de la personnalité :

- Modalité de l'**expérience vécue** et des **conduites** qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu.
- Touche l'**ensemble** du fonctionnement du sujet: cognitif, affectif, comportemental (impulsivité), relationnel (si touche uniquement une partie du caractère, ne peut pas être diagnostiqué comme trouble de la personnalité).
- **Durable, rigide et envahissant** (pas uniquement en période de crise, p ex).
- Décelable **au plus tard à l'adolescence** ou au début de l'âge adulte.

Catégories

À utiliser comme des prototypes, modèles ou repères, pas comme des définitions absolues. Souvent, plusieurs catégories sont nécessaires à définir une personne :

Groupe A (bizarre) :

- Personnalité schizotypique
- Personnalité schizoïde
- Personnalité paranoïaque

Groupe B (dramatique) :

- Personnalité antisociale
- Personnalité borderline
- Personnalité histrionique
- Personnalité narcissique

Groupe C (anxieux) :

- Personnalité évitante
- Personnalité dépendante
- Personnalité obsessionnelle compulsive

Et trouble de la personnalité non-spécifié.

Le diagnostic est difficile, car la souffrance souvent diffuse et difficile à mettre en mot. Le trouble altère globalement toute la vie du patient, et c'est un facteur de risque pour les troubles de l'axe I (troubles de l'humeur et troubles anxieux). Comme les troubles touchent la vision des autres, la vision de soi et la communication, l'entourage est souvent très affecté.

De plus, complique la relation médecin-patient, et peut être très difficile à recevoir comme diagnostic (vexant).

Nécessite des traitements longs et souvent difficiles (4-6ans), mais souvent **curatif**, surtout pour le plus fréquent, qui est le bordeline. Souvent, **comorbidité** avec troubles dépressifs et anxieux.

Tous ces troubles ont des prévalences d'environ 2-3%.

Problèmes et limites

Comment définir le normal et le pathologique ?

On peut utiliser des critères **statistiques** : est pathologique ce qui dévie de la norme.

Ex : **les Big Five**

Sur la base d'analyses statistiques de questionnaires remplis par les sujets, il est possible de mettre en évidence cinq facteurs:

- I. Extraverti (cherchant le contact)
- II. Agréable (chaleureux, sociable)
- III. Conscientieux (responsable, réfléchi)
- IV. Névrosé (anxieux)
- V. Ouvert (curieux)

Des critères **dimensionnels** (valeur extrême de la dimension définie), **catégoriels** (correspondant aux critères du pathologique défini *à priori*), **adaptatifs** (qui entrave l'adaptabilité sociale) ou **subjectif** (qui cause une souffrance ou un conflit intrapsychique) sont aussi utilisés.

Notion de **spectre** : pour les troubles schizophrénique et bipolaire, on peut observer un spectre (ou éventail) de troubles, qui reposent probablement sur un **fond génétique commun**.

Il y a ainsi un **continuum** entre personnalité schizothyme, schizoïde et schizophrénie, ainsi qu'entre cyclothyme, cycloïde et trouble bipolaire.

Limites du système catégoriel : La CIM-10 ne définit pas tous les mêmes troubles, ce qui montre bien la limite de leur définition. Ces limites de définition se montrent aussi par la difficulté à indiquer leur prévalence.

Instabilité du diagnostic : sur une année, les patients ne correspondent pas toujours aux critères diagnostics, car de nombreuses personnes sont proches du seuil considéré comme pathologique, et le dépassent de temps en temps, lors de périodes de vie plus difficiles. Le récit de vie (qui permet de détecter ou non que le trouble est présent dès l'adolescence) est également coloré par l'état au moment du récit. On ne peut donc **jamais** poser un diagnostic de trouble de la personnalité après **une seule** crise ou une seule consultation.

Diagnostic

L'entretien clinique usuel est peu performant pour ce type de diagnostic.

Devant un suivi difficile, un patient qui se met plusieurs fois dans le même type de situation, se poser la question d'un tel diagnostic.

Des instruments standardisés existent (listes de questions), mais sont astreignants.

Des entretiens de type psychodynamique, menés par des psychologues spécialisés, ont une bonne validité.

Groupe A : Bizarres et excentriques

Personnalité paranoïaque

Le motif de consultation est souvent un épisode dépressif majeur, consécutif à la difficulté d'adaptation à un environnement (p ex militaire, police).

Caractéristiques :

- Hypertrophie du moi: **égocentrisme**, surestimation de soi
- Psychorigide: autoritarisme, ne doute jamais
- **Méfiance**: s'attend à ce qu'on l'exploite ou le trompe, doutes de la fidélité de ses amis, de son conjoint, ne se confie pas
- Susceptible, interprétatif, suspicieux, et **rancunier**

Trouvé chez un certain nombre de délinquants sexuels. Fait partie de trouble du spectre de la schizophrénie.

Fait partie des troubles difficiles à traiter (ne supportent pas l'échec ni la remise en question, le traitement lui-même peut provoquer un épisode dépressif majeur).

Personnalité schizoïde

Retrait par rapport aux relations sociales : solitaire, ne cherche ni n'apprécie les relations proches, peu d'intérêt pour les relations sexuelles.

Pauvreté du registre émotionnel : indifférence aux critiques et aux éloges, peu d'activités qui procurent du plaisir, **froideur affective**.

Plus fréquent chez les hommes. Ne fait probablement **pas** partie du spectre de la schizophrénie.

Personnalité schizotypique

Gênes dans les relations proches : anxiété, maladresses (pas de théorie de l'esprit: incapacité à interpréter et se mettre à la place de l'autre) et isolement social.

Distorsions perceptives et cognitives :

- Troubles de la **perception**
- Troubles "fins" du discours et de la pensée : **utilisation bizarre de la langue** comme "sphère vicieuse" au lieu de "cercle vicieux", mauvaise différenciation entre soi et les autres, etc. Apprendre à les repérer, car automatiquement, on "corrige" toujours ce que les autres disent pour donner un sens.
- Croyances bizarres, pensée magique
- Idées de référence (des événements quelconques sont référés à soi)

Pauvreté ou **inadéquation** des affects (rire inadéquat), conduites **excentriques**.

Fait partie du spectre de la schizophrénie ("personnalité pré-morbide"). La psychothérapie peut permettre de trouver des stratégies et aide en général beaucoup (rassurer sur les angoisses).

Les neuroleptiques sont parfois utiles.

Groupe B : dramatiques

Personnalité anti-sociale

Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui : **incapacité à se conformer** aux règles et aux normes, tendance à **tromper par profit ou plaisir**, absence de culpabilité, d'empathie et de remords. Aucune théorie de l'esprit, donc incapacité à se mettre à la place d'autrui.

Irritabilité et agressivité, et incapacité à avoir des relations durables.

Peut faire suite à un trouble des conduites à l'adolescence, étiologie discutée. Plus fréquent chez les hommes.

=> délinquance, notamment sexuelle. Dangereux! S'ils sont intelligents, peuvent manipuler l'entourage. Peu de mesures thérapeutiques possibles. **Contre-indication** à la psychothérapie.

Personnalité borderline

Perturbation des **émotions** :

- Réactivité marquée de l'humeur (rapidement triste, joyeux, angoissé..)
- Colères intenses et inappropriées
- Sentiments de vide

Impulsivité :

- Gestes ou menaces suicidaires (impulsifs), ou auto-mutilations
- Addictions
- Troubles alimentaires

Perturbation de l'**identité** :

- Instabilité de l'image de soi et des autres (se décrivent ou décrivent les autres de manière très caricaturale, et variable)
- Idéation persécutoire

Relations interpersonnelles instables et intenses :

- Idéalisation et dévalorisation
- Craintes d'abandon

Peut se repérer par le syndrome d'**identité diffuse** : Sentiment de flou, de contradiction, instabilité émotionnelle, empathie difficile ou partielle. Les mécanismes de défense portent atteinte à la nature du lien entre représentation de soi et d'objet. Ils sont : clivage, déni des certains aspects de la réalité, omnipotence, dévalorisation.

Plus fréquent chez les femmes. Peut s'améliorer avec les années, et répond assez bien à la psychothérapie.

DD entre **dépressivité borderline** et **épisode dépressif majeur** :

Dans la personnalité borderline, l'humeur a des brusques variations (et non stablement dépressive), et elle est réactionnelle à des stimuli environnementaux (et non accompagnée d'une perte d'intérêt pour l'environnement). Les critiques sont adressées à autrui (et non un sentiment de culpabilité). En cas de tentative de suicide, elle est impulsive, sans idée de mort (et non précédée et accompagnée d'idée de mort). Le fonctionnement est instable entre les épisodes (et non stable ou légèrement déprimé). Un sentiment de solitude, de vide et d'ennui alterne avec des sentiments de rage et de frustration (et non culpabilité, remord, baisse de l'estime de soi).

La distinction est importante car la dépressivité ne se traite pas par des antidépresseurs, mais l'EDM oui. Attention, il peut y avoir une co-morbidité.

DD avec **trouble bipolaire** :

Pas d'épisode psychotique dans les troubles borderline.

Etiologie discutées :

Vulnérabilité génétique, activité sérotoninergique, expériences de séparation et de perte, troubles psychiatriques familiaux, négligence et contrôle excessif, abus sexuels...

Traitement :

Pas de traitement standardisé. Le plus important est l'alliance thérapeutique, car les ruptures sont fréquentes => **contrat thérapeutique**. Le thérapeute ne peut pas interpréter directement les conflits, mais peut relever la confusion, tester l'épreuve de réalité, montrer au patient comment il se défend, mais attention aux affects agressifs. Un travail plurimodal peut être nécessaire, avec un soutien psychosocial et des hospitalisations lors des crises.

TTT souvent psychodynamique ou TCC, de longue durée (5ans ou plus).

Les **médicaments** ne traitent pas la pathologie de caractère. Ils peuvent être nécessaires pour traiter les comorbidités symptomatiques.

Personnalité histrionique

Peu de différence avec borderline. Définition (discutable) :

- Réponse **émotionnelle** excessive : manière de parler subjective et pauvre en détails, relations considérées comme plus intimes qu'elles ne le sont
- Quête d'**attention** et dramatisation, théâtralisme et exagération de l'expression émotionnelle
- Suggestibilité : facilement influencé par autrui ou les circonstances

Plus fréquent chez les femmes. Donjuanisme chez les hommes.

Etiologie psychologique : perturbation des relations pendant la petite enfance.

Traitement psychothérapeutique.

Personnalité narcissique

Paradoxe entre sens grandiose de sa propre importance, fantaisie de succès illimité, pense être spécial et unique, etc, et aussi besoin excessif d'être admiré, envie les autres, croit que les autres l'envient. Les comportements sont volontiers arrogants et hautains, avec un manque d'empathie.

La validité du diagnostic est discutée. Caractérise plus probablement des traits de caractères ou une problématique psychique qu'une véritable pathologie du caractère.

Groupe C : anxieux

Plus stables émotionnellement, et ayant une bonne conscience de leur difficulté.

Estime de soi lacunaire. Souvent les deux premiers types de comportements sont présents ensemble.

Personnalité évitante

=> évite les relations par peur de ne pas être apprécié, se considère comme socialement incompetent, sans attrait, inférieur aux autres.

DD : phobie sociale et personnalité schizoïde.

Apparaît souvent dans l'enfance.

Personnalité dépendante

Réaction exactement inverse : besoin général et excessif d'être pris en charge.

Comportement soumis et passif, angoisse de séparation.

Plus fréquent chez les femmes.

Peut se compliquer en état dépressif majeur.

Traitement : psychothérapie.

Personnalité obsessionnelle compulsive

Caractère du patient avec TOC, sans les obsessions ou compulsions.

Besoin excessif d'ordre matériel et moral : préoccupation pour les règles et l'organisation au point que le but principal de l'activité est perdu de vue ; perfectionnisme.

Entêtement, rigidité : réticence à travailler avec autrui à moins que les autres se soumettent exactement à la manière de faire les choses.

Soucis d'économie.

Tendance aux doutes et aux scrupules, indécision.

Plus fréquent chez les hommes.

Complications : EDM, dépendance OH.

Traitement : psychothérapie.

Les addictions

Contexte et vignettes cliniques

La Suisse a été traumatisée par la drogue. Dans les années 1980, la consommation était très étendue, et les injections se faisaient dans les parcs publics.

=> mise en place des 4 piliers : **prévention, répression, thérapie et aide à la survie.**

Particularité de l'addictologie : "tout le monde est expert", forte implication politique et émotionnelle dans les discours de santé publique.

Défis actuels :

- Diminution de l'âge des consommateurs (=> 10 ans entre première consommation et premier contact avec soins)
- Augmentation de l'accessibilité aux substances
- Polymorbidité médico-psycho-sociale

En 20ans, la médecine a passé du jugement **moral** (addictions = vice, mauvaise volonté, paresse, certaines substances sont diabolisées tandis que d'autres sont banalisées), au jugement **clinique** :

L'addiction est une **maladie complexe**, au carrefour entre psychosomatique et psychosocial.

Elle repose sur des **vulnérabilités** biologiques, psychologiques et sociales.

=> fondements scientifiques, traitements basés sur l'evidence-based medicine.

Jeune homme de 19 ans, informaticien

Demande des benzodiazépines pour un trouble du sommeil

Fatigue, stress, suspicion de dépression

Troubles de la concentration

A l'anamnèse systématique : cannabis tous les soirs.

=> avis demandé au centre d'addiction.

=> équipe mobile pour les patients addicts au cannabis, envoyée chez les MPR.

Représentant de commerce, 50 ans

Boit un litre de vin par jour, "professionnellement".

Pas de problèmes psycho-sociaux

Gamma GT limite sup, HTA légère

Ne pas stigmatiser et se mettre le patient à dos en lui disant d'emblée qu'il est alcoolique.

Mère de famille, 35 ans

Abus d'alcool, prise chronique de benzo

Cocaïne le week-end, sniffs réguliers d'héroïne (1ère prise le matin)

Dysthymie

Enfants à charge

=> aide sociale, soutien familial. Si possible, maintien de la garde des enfants.

Addictologie : nécessite des équipes mobiles et du travail de réseau.

Type de substances et d'addictions**Psycholeptiques**

Groupes de **sédatifs** ou dépresseurs du SNC : Alcool, benzodiazépines, barbituriques, GHB, opiacés.

A petite dose : désinhibition, anxiolyse.

A haute dose : sédation, coma, arrêt respiratoire.

Psychoanaleptiques

Groupe de **stimulants** du SNC : caféine, nicotine, amphétamines et dérivés (ecstasy, MDMA, pilules thaïes), cocaïne.

NB : 3-5% des Suisses consomment de la cocaïne.

Effets recherchés : euphorie, entactogène (favoriser le contact) .

Effets somatiques : excitation, hypertension (effets cardiaques), convulsions (état de mal épileptique).

Effets psychiques : agitation, diminution du sommeil, stimulation libido (=> viols!), compulsion, paranoïa.

Psychodysléptiques

Groupe des **perturbateurs** du SNC : cannabis, solvants, mescaline, LSD, phencyclidine (angel dust).

Effets recherchés : « déconnexion ».

Effets psychiques : dissociation, panique, paranoïa, hallucinations.

Comportements addictifs

Trouble du contrôle des impulsions

Jeu pathologique

Achats compulsifs

Cyberaddiction (10% de la population)

Addiction sexuelle

Addiction amoureuse : recherche de l'état d'énamoration, relations fréquentes.

Le cas des troubles alimentaires : pas considérés comme addictions en Suisse, mais en France oui.

Classification et diagnostic

Définitions :

- **Addiction** : asservissement par le corps (avec ou sans substances psycho-actives); comportement de recherche active; automatisations.
- **Dépendance** : syndrome *avec symptômes* psychobiologiques (sevrage, tolérance). Degré plus sévère de l'addiction.
- **Abus** : problèmes avérés.
- Consommation à risque : problème *potentiel*.
- Consommation récréative. Existe pour chaque substance.

Dans le DSM-IV, on différenciait l'abus de la dépendance (plus grave). Dans le DSM-V, ils ne sont plus différenciés (les deux sous le terme de Substance Use Disorder), et les addictions comportementales y ont été ajoutées.

Le craving a été ajouté comme critère, et les problèmes avec la justice ont été enlevés.

DSM-V : Substance use disorder

C'est un seul trouble, de léger à sévère. Défini par la présence de 2-3 symptômes parmi 11:

1. Taking the substance in larger amounts or for longer than the you meant to
2. Wanting to cut down or stop using the substance but not managing to
3. Spending a lot of time getting, using, or recovering from use of the substance
4. Cravings and urges to use the substance
5. Not managing to do what you should at work, home or school, because of substance use
6. Continuing to use, even when it causes problems in relationships
7. Giving up important social, occupational or recreational activities because of substance use
8. Using substances again and again, even when it puts you in danger
9. Continuing to use, even when the you know you have a physical or psychological problem that could have been caused or made worse by the substance
10. Needing more of the substance to get the effect you want (tolerance)
11. Development of withdrawal symptoms, which can be relieved by taking more of the substance.

Addictive disorder

Includes gambling disorder (sole condition...)

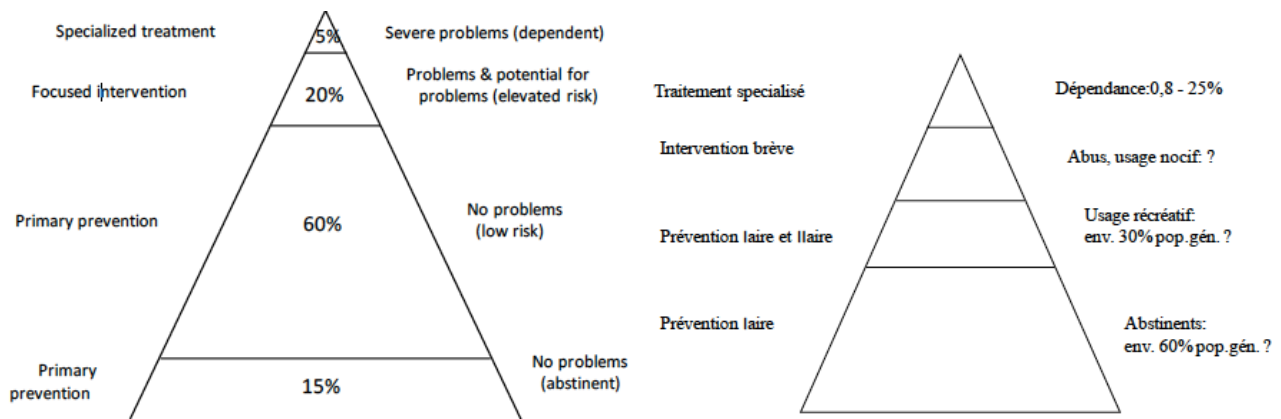
CIM-10 : La classification utilise des codes de numéros : F pour trouble mental, 10 pour abus de substance, 0-9 pour indiquer le type de substance, 0.0 à 0.9 pour le type d'utilisation (aigüe, nocive, dépendance...).

Au-delà de ce diagnostic sur des critères, la prise en charge nécessite un diagnostic des comorbidités, des motivations, et de l'environnement significatif.

Profils de consommation

Pour les différentes substances, on peut établir un profil d'utilisation par la population, associé avec les interventions qu'elles nécessitent :

Cette pyramide est assez bien connue pour l'alcool (à gauche : 60% de consommation à risque faible, concernés par la prévention primaire, 20% de risque élevé, concernés par des interventions spécifiques, et 5% de la population avec des problèmes sévères, nécessitant un traitement spécialisé), mais les données pour le cannabis sont beaucoup moins claires (à droite).



Cette répartition indique la population “épidémiologique”, qui est encore bien différente de la population “clinique”, soit celle qui l’on peut voir en consultation.

Fondements neurobiologiques

La **dopamine** a un rôle central dans le plaisir, naturel et artificiel (sous substance). La même aire cérébrale que celle des émotions est impliquée. L'**amygdale** est le lieu du “craving”. Elle a un rôle central et accorde une valeur émotionnelle (peur, anxiété).

Le **stress** (et ses conséquences neuro-hormonales) est une vulnérabilité pour les addictions, en lien avec le **cortisol** : les souris sans cortisol ne s’administrent pas de drogue.

Génétique : des polymorphismes notamment dans les gènes liés à la dopamine, confirment une vulnérabilité génétique à l’addiction. L’environnement a cependant un rôle très important aussi (avec des répercussions au niveau moléculaire, sur les transcriptases).

Plasticité : des modifications structurales durables et une mémoire addictive s’installent. Mais la plasticité permet aussi leur modulation !

Messages :

Addictions : une politique suisse face à un problème majeur de santé mentale.

Une clinique hétérogène et fréquente pour les médecins.

Diagnostic multidimensionnel, comorbidités fréquentes.

Des fondements neurobiologiques biopsychosociaux et une plasticité.

Crise suicidaire

Épidémiologie

En Suisse, prévalence de 19/100'000 habitants. Principale cause de mort violente, avant les accidents. 2^{ème} cause de mortalité chez les 15-20ans.

Diminution de 20% entre 1992 et 2002.

Les hommes décèdent plus souvent de leurs tentatives de suicide que les femmes, même s'ils en font moins. Causes : plus souvent moyens violents (pendaison et armes à feu, plus efficaces), moins souvent médicaments.

Les autopsies psychologiques (auprès des proches) ont montré que dans 90% des suicides, il y avait un diagnostic de trouble psychiatrique qui aurait pu être fait.

Caractéristiques du passage à l'acte suicidaire selon le trouble psychiatrique sous-jacent

Troubles affectifs et suicide

Le suicide est plus fréquent dans les premiers épisodes dépressifs. 4% des patients dépressifs se suicident.

Cave les ttt anti-dépresseurs augmentent transitoirement le risque de suicide.

10-15% des patients bipolaires se suicident. Le lithium aurait un effet préventif spécifique.

Suicide et alcool

L'alcool augmente le risque d'agir suite à des impulsions suicidaires.

10% de risque chez les alcoolo-dépendants.

70% des suicides de jeunes aux USA font intervenir l'alcool.

Suicide et schizophrénie

5% des patients se suicident, souvent en lien avec les symptômes négatifs (rarement les symptômes positifs). Les facteurs de risque sont : mauvaise compliance, abus de substance, antécédent de tentative de suicide.

Suicide et troubles de la personnalité

Les personnalités émotionnellement labiles et antisociales présentent plus de risque de suicide. La théorie psychodynamique l'explique par la présence d'une agressivité qui peut être retournée contre soi.

Suicide et santé physique

Le contexte de maladie **somatique grave** (cancer, HIV avant les traitements, douleurs, SEP, épilepsie, lupus, lésion de moelle...) est également une cause de suicide.

Les **personnes âgées** sont également à risque.

Modèles explicatifs

Génétique

Le risque est plus élevé en cas d'histoire familiale de suicide. Gènes candidats : tryptophane hydroxylase, transporteurs à la sérotonine.

Neurobiologie

Axes de recherche : modification du système sérotoninergique (régulation de l'impulsivité, agressivité, troubles cognitifs..) ou altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire (régulation du stress).

Prise en charge

La prédiction du suicide est difficile.

Chaque personne dépressive devrait être investiguée pour un risque suicidaire.

La personne peut le voir comme un droit fondamental, et l'intervention n'est pas toujours évidente et peut faire face à des questionnements philosophiques profonds.

La vision actuelle est celle que l'intervention médicale peut servir à aider la personne à sortir de sa vision dans laquelle le suicide est la seule issue possible, à l'aider à trouver d'autres voies, d'autres ressources.

Les tentatives de suicides sont le facteur prédicteur le plus important pour le suicide : 1-6% des suicides ont lieu dans l'année après une tentative.

Évaluation du potentiel suicidaire (échelle RUD)

Facteurs de risque :

- **Tentative** précédente
- Trouble psychiatriques
- Troubles somatiques
- Crises relationnelles ou professionnelles
- Accès aux moyens
- **Isolement**
- Exposition au suicide (proches ou personnes célèbres)

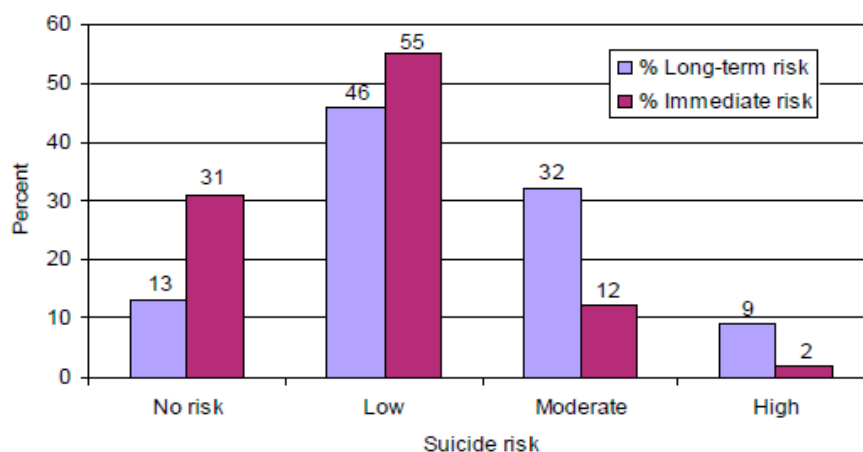
Urgence : imminence de la volonté de suicide

- Intention claire
- Planification claire
- Patient déterminé, coupé de ses affects

Dangerosité : accessibilité directe au moyen envisagé pour le suicide et "efficacité" du moyen

Permet d'estimer un **potentiel suicidaire** (et non un risque).

En réalité, l'évaluation est assez mauvaise : 55% des patients considérés "low-risk" se sont suicidés.



Les mesures à prendre

Hospitalisation (volontaire ou en PLAFA), si le potentiel est élevé (+/- suivi 1:1, avec un infirmier assigné au patient pour tenter de le “surveiller”). Eventuellement neuroleptiques pour calmer l’impulsion. A la sortie de l’hôpital, le risque est élevé => case management de transition, avec suivi quotidien à domicile.

Suivi ambulatoire rapproché si le risque paraît moins élevé **et** qu’une alliance thérapeutique peut se construire.

Prévention

Retrait de l’accès à certaines méthodes : retrait des armes, de toxiques, mesures publiques (barrières sur les ponts, catalyseurs sur les voitures).

Programmes de prévention ciblé (groupes à risque, prévention scolaire).

=> l’efficacité a été établie dans plusieurs pays.

Conclusion :

Tout médecin doit pouvoir faire une évaluation du risque.

Aborder le sujet, en parler!!

Anti-dépresseurs et anti-psychotiques

Anti-psychotiques : mécanismes et cibles

Parmi les 10 médicaments les plus prescrits, on trouve 3 médicaments psychiatriques.

Indications des anti-psychotiques :

Schizophrénie aiguë et chronique

Syndromes paranoïdes hallucinatoires

Manies et états maniaques (troubles bipolaires)

Episodes dépressifs lors de troubles bipolaires

Etats d'agitation psychomotrice

Antéméique: droperidol (Droperidol®), metoclopramide (Primperan®)

Traitement de la schizophrénie

La posologie, le médicament et la voie d'administration dépendent de plusieurs facteurs :

- Diagnostic, symptomatologie (si très agité, voie *im* nécessaire)
- Efficacité (certains sont plus efficaces que d'autres)
- Effets secondaires et sensibilité du patient à ces effets
- Interactions (+/- métabolisme par CYP450)

NB : il n'y a pas de biomarqueur permettant de prédire la réponse au traitement.

Mécanismes

Les anti-psychotiques agissent sur les récepteurs D2 pré- et post-synaptiques, mais aussi D1 post-synaptiques => modulation de l'activité dopaminergique.

Les stimulants (certaines drogues) inhibent les transporteurs permettant la recapture de la dopamine. Le lithium diminue également la concentration synaptique de dopamine en agissant présynaptiquement.

Pathophysiologie de la psychose :

Les symptômes psychotiques expriment une hyperstimulation des neurones pyramidaux du **néocortex**, en réponse aux stimuli glutamatergiques des noyaux **thalamiques** (relai des afférences sensorielles).

Cette stimulation est contrôlée par différentes voies, dont la voie **dopaminergique**, qui augmente la réponse au glutamate. L'activation de la voie **sérotoninergique** (5HT2A) facilite également la libération de glutamate (cible des nouveaux ttt).

L'hyperstimulation est modulée par les projections **cholinergiques** et **noradrénergiques**, depuis le tronc.

Effets de substances sur ces réseaux :

- Agonistes dopaminergiques et noradrénergiques (cocaïne, amphétamines): augmentation de la réponse à l'excitation glutamatergique => stimulation
- Agonistes sérotoninergiques (hallucinogènes) : facilitation présynaptique de la libération de glutamate
- Antagonistes glutamate-N-méthyl-aspartate (anesthésiques dissociatifs, phencyclidine) : diminution de l'activation **glutamatergique** des interneurones, ce qui augmente l'activation des neurones pyramidaux
- Antagonistes à l'Ach (atropine) : diminution de l'activation **cholinergique** des interneurones, ce qui augmente l'activation des neurones pyramidaux

Médicaments agissant sur ces réseaux :

La **clozapine** est le plus efficace, mais elle a aussi de nombreux effets IIres.

L'**aripiprazole** est un agoniste partiel. S'il y a une hyperactivité D2, il la diminue, mais s'il y a une hypoactivité, il l'augmente.

L'amisulpride a une certaine sélectivité (antagoniste D2 et D3), et bloque les récepteurs uniquement dans le cortex, pas dans les ganglions de la base.

Pharmacocinétique

Relation dose-effet : Il y a une bonne corrélation entre dose clinique et affinité pour le récepteur D2. Donc, plus le médicament est puissant (IC50 bas, affinité forte), plus la dose prescrite est faible.

Relation occupation des récepteurs et dose : La **marge thérapeutique** se situe aux doses auxquelles **60-80%** des récepteurs D2 sont occupés (peut s'étudier au PET-scan). Au-delà de 80%, les effets extra-pyramidaux augmentent nettement.

Antipsychotiques typiques

Ils peuvent être **incisifs** ou **sédatifs**.

Les traitements incisifs sont principalement des antagonistes aux récepteurs D2.

Molécules : **Halopéridol** (Haldol®), Orap (Pimozide®).

Ils sont habituellement prescrits en **petites** doses.

Ils ont des risques d'**effets extra-pyramidaux** => parkinsonisme, dyskinésie, dystonie, acathisie (impossibilité à rester en place).

Bonne efficacité sur les symptômes positifs, mais peu efficaces contre les symptômes négatifs.

Les traitements sédatifs sont des antagonistes D2 mais aussi à d'autres récepteurs, notamment H1, cholinergiques et adrénergiques.

Molécules : **Levémépromazine** (Nozinan®), Zuclopentixol (Clopixol®).

Ils sont habituellement prescrits à **hautes** doses.

La sédation est un effet Ire ou IIre, suivant l'utilisation. Parfois, combinés à un anti-psychotique classique incisif.

Effets secondaires

- Effets indésirables fréquents (sédatifs):

- Sédation (via récepteurs H1)
- Anti-cholinergique (déficit de l'accommodation, constipation, rétention urinaire)
- Anti-adrénergique (hypotension orthostatique)
- Métabolisme: prise de poids (récepteurs H1 plus multiples autres récepteurs), hyperglycémie

- Effets indésirables fréquents (sédatifs et incisifs):

- Hyperprolactinémie (aménorrhée, gynécomastie, galactorrhée) par action sur la voie tubéro-infundibulaire (projection sur l'hypophyse)
- Effets extrapyramidaux :
 - Syndrome de Parkinson (akinésie, tremblement, rigidité) très fréquents (>10% des patients) => traitement : **anticholinergiques** (durée à réévaluer au cours du traitement, car les neurones cholinergiques et dopaminergiques sont connectés dans la voie nigrostriée)
 - Dyskinésies tardives (mouvements anormaux bouche, extrémités, tronc) après traitement prolongé (6 mois de thérapie chez 10-20% des patients, fréquence

dépend notamment de la dose et des types de dyskinésies; 5-40% de rémissions, certaines dyskinésies tardives irréversibles)

- Effet indésirable plus rare (fréquence plus élevée parmi les typiques que les atypiques)
 - Syndrome malin des neuroleptiques : hyperthermie, rigidité musculaire, troubles neurovégétatifs, altération de l'état de conscience: peut conduire à une décès dans environ 10% des cas

Limites des neuroleptiques typiques :

Leurs effets sur les symptômes négatifs et cognitifs sont insuffisants.

Les effets secondaires sont importants (aussi prolongation du QT et problèmes cognitifs).

Neuroleptiques atypiques

Ce sont tous des antagonistes D2 (sauf l'aripiprazole, agoniste partiel D2) et tous aussi antagonistes 5HT2A (sauf l'amisulpride).

Ils ont moins d'effets extra-pyramidaux et un risque diminué de dyskinésie tardive. Ce sont donc les anti-psychotiques à prescrire en première intention.

Moins d'hyperprolactinémie (dose-dépendant). L'efficacité est plus grande sur les symptômes négatifs (mais pas optimaux).

Plus de risque de prise de poids.

Quelques exemples de molécules :

Clozapine (Leponex®)

Le plus efficace, mais attention à l'agranulocytose.

Effets indésirables:

- Somnolence, hypotension, antimuscariniques
- Troubles métaboliques: prise de poids (+++), hyperglycémie, hypertriglyc/cholestérolémie

Toxicité : **agranulocytose** dans 1-2% des cas! Contrôles ***hématologiques*** obligatoires!

Olanzapine (Zyprexa®)

Effets indésirables: Pas d'agranulocytose !

- Somnolence, hypotension, antimuscariniques
- Métabolisme: prise de poids (+++), hyperglycémie, hypertriglyc/cholestérol-émie

Risperidone (Risperdal®)

Effets indésirables:

- Hypotension, vision trouble, troubles de la concentration
- Troubles métaboliques: prise de poids (++)

Quetiapine (Séroquel®)

Anti-dépresseurs : principes et cibles

Indications : Dépression, troubles anxieux, troubles paniques, TOC.

NB : le traitement de base du trouble **anxieux** est l'anti-dépresseur, et non les benzodiazépines!

Principe

Augmentation (potentialisation) de la neurotransmission **monoaminergique** (noradrénaline, sérotonine). *Cave* : Effet antidépresseur **après 2 semaines** environ (attention aux tendances suicidaires dans les premières semaines, surtout avec les tricycliques, qui sont très toxiques en surdosage => faire des ordonnances de courte durée).

Explication de la latence d'action : Par blocage du transporteur, augmentation de la concentration de sérotonine synaptique => activation des récepteurs *pré-synaptiques*, qui conduisent à une diminution de la libération de sérotonine (feedback négatif). Après deux semaines, down-regulation de ces récepteurs pré-synaptiques => augmentation de la libération des mono-amines.

Fonctions attribuées à ces neuro-transmetteurs :

Les trois sont impliqués dans l'humeur, l'émotion et les fonctions cognitives.

NA ; surtout vigilance, sérotonine : surtout impulsion, dopamine : surtout élan.

NA et sérotonine : anxiété et irritabilité.

NA et dopamine : motivation.

Sérotonine et dopamine : appétit, agression, sexualité.

Cibles pharmacologiques potentielles :

1. Précurseur de sérotonine (p ex tryptophane)
2. Antagonisme des récepteurs 5HT2 (trazodone, mirtazapine)
3. Bloc de la recapture : uniquement sérotonine (SSRI), ou sérotonine et NA (tricycliques, SNRI et autres)
4. Bloc de la dégradation : IMAO

Sérotonine et théorie neurotrophique

Implications du système sérotoninergique dans la dépression :

- Les patients déprimés ont moins de produit de dégradation de sérotonine dans leur LCR..
 - La déplétion en précurseur de sérotonine (tryptophane) fait rechuter les patients traités
- Mais, la sérotonine n'explique pas tout.

Les récepteurs à tous des NT stimulent des voies de signalisation qui aboutissent à l'expression du **BDNF** (Brain derived neurotrophic factor), qui stimule la neurogenèse, la survie et la fonction neuronale.

Hypothèse : dans la dépression, il y a une down-regulation du BDNF (augmentée par les glucocorticoïdes, donc le stress) et donc une diminution des connexions synaptiques. Le traitement rétablit les connexions synaptiques.

On observe une augmentation d'activité cérébrale dans le cortex frontal médian, subgénéral (sous le genou du corps calleux) et dans l'amygdale pendant la dépression.

Dans les états de tristesse transitoire, l'activité du cortex cingulaire subgénéral est augmentée,

Or, sous fluoxétine dans la dépression chronique et dans la dépression liée à Parkinson, cette activité diminue. Mais **aussi** sous **placebo**.

L'activité de base de cette zone permet parfois de prédire la réponse au traitement.

Les anti-dépresseurs

Connaître les SSRI.

Attendre 2 semaines pour l'effet, mais réagir si aucun effet après 1 mois!

Tricycliques : imipramine, **amitriptyline** et clomipramine

Mécanismes :

- Inhibition de la recapture des monoamines (NA, 5-HT)
- Interaction avec plusieurs récepteurs (muscariniques, α 1-adrénériques et à l'histamine)
- Interactions avec canaux Na^+ et autres

Effets indésirables:

Effets anti-muscariniques (sécheresse bouche, rétention urinaire, augmentation de la pression intraoculaire, confusion mentale)

Effets anti-histaminergiques – sédation

Effets anti- α adrénériques - hypotension orthostatique

Arythmies graves, bloc AV – interaction avec canaux Na^+

Prise de poids (multiples récepteurs)

Dysfonctions sexuelles

Toxicité aiguë (tentamen)

Excitation, convulsions

Dépression respiratoire, coma

Arythmies

SSRI : Fluoxétine, Paroxétine, **Sertaline**, **Citalopram**, Fluvoxamine..,

Moins d'effets IIres que les tricycliques, éventuellement moins de toxicité aiguë et de risque de suicide, mais plus d'anxiété, insomnie, céphalées...

Effets secondaires

Anxiété, insomnie, céphalées

Troubles sexuels

Nausées, diarrhées, perte d'appétit

Syndrome de discontinuation sérotoninergique: irritabilité, nausée, sensations de chocs électriques, insomnie, sueurs profuses (pas une dépendance !)

Pharmacocinétique :

Attention, inhibition des P450 (fluoxétine, paroxétine (CYP2D6), fluvoxamine (CYP1A2) > citalopram, sertraline)

SNRI (noradrénaline et sérotonine) : **venlafaxine**, duloxétine

Mécanismes et efficacité

Profil d'affinité pour l'inhibition de la recapture de la sérotonine et la noradrénaline identique aux antidépresseurs tricycliques. Affinité plus faible pour les récepteurs muscariniques, H_1 et adrénériques que les tricycliques => Moins d'effets indésirables potentiels que les tricycliques

Effets indésirables:

Profil similaire aux SSRI pour les effets sérotoninergiques (troubles gastro-intestinaux etc) et SNRI pour les effets noradrénergiques (hypotension orthostatique etc)

Antidépresseurs sélectifs sérotoninergiques et noradrénergiques: **mirtazapine**

Mécanisme :

Pas de blocage de transporteurs mais stimule la libération de sérotonine et effet noradrénergique

Effets IIres :

Sédatif (anti H1) et prise de poids

Peu / pas d'effets gastro-intestinaux et sexuels

IMAO : **moclobémide**

Mécanisme, effets :

Inhibition des enzymes dégradants les monoamines => Augmentation des niveaux de monoamines dans le SNC.

Pas utilisé en première intention, car toxicité et interactions.

Effets IIres et interactions :

Augmentation des effets des amines sympathomimétiques, tels que la **tyramine** (dans le fromage et le tofu, aussi dégradé par les MAO dans le foie et les intestins) => s'accumule dans les terminaisons synaptiques.

Excitation (insomnie, tremblement, convulsions)

Hépatotoxicité

Cave au syndrome sérotoninergique si associé avec un antidépresseur sérotoninergique => CI!!!

Aussi lors du passage de l'un à l'autre (=> attendre l'élimination totale dans l'organisme).

Présentation : mydriase, agitation, confusion, coma, hypertension, tachycardie, hyperthermie, clonus, hyperréflexie..

Efficacité

Problématique : Notamment pour les tricycliques, les doses efficaces sont supérieures aux doses initiales et souvent aussi supérieures aux doses utilisées (à cause des effets secondaires). De plus, toxicité cardiaque, toxicité en surdosage => tricycliques utilisés rarement, surtout dans des cas de non-réponses aux autres antidépresseurs

Biais de publication : les études montrant l'efficacité sont plus publiées que les études montrant la non-efficacité.

En tous les cas, évaluer l'utilité de la prescription au cas par cas. Pas de prescription pour les dépressions légères à modérées.

Pour les antidépresseurs examinés dans une méta-analyse (Cipriani, 2011), la **sertraline**, le (S)-**citalopram**, la **venlafaxine** et la **mirtazapine** semblent les plus efficaces.

Ces résultats restent non-absolus. Différence modérée mais à défaut ces résultats peuvent être utilisés comme première indication (de plus ces 4 médicaments ont un faible potentiel d'interaction avec les cytochromes P450).

Lithium

Mécanismes et effets:

L'inhibition du métabolisme des phospho-inositides est probablement lié à l'effet anti-maniaque/ antidépresseur.

Usage clinique (pas classé comme antidépresseur mais stabilisateur de l'humeur) :

- Traitement des phases aiguës et prophylaxie à long terme de la maladie maniaco-dépressive (phases maniaques et dépressives).
- Potentialisation de l'effet antidépresseur (ajout lors d'une non-réponse sur un traitement antidépresseur dans une dépression unipolaire).

Effets indésirables (marge thérapeutique étroite, **dosage sanguin obligatoire**):

- Tremblement
- Nausées, diarrhée
- Fatigue
- **Diabète insipide** rénal (inhibition de la sécrétion de vasopressine)
- Rétention de Na⁺ et oedèmes

Plus rarement:

- Toxicité rénale (particulièrement aux taux sanguins élevés)
- Arythmies
- Intoxication : vomissements, diarrhées, tremblements, ataxie, coma, convulsions

Durée des traitements

En cas de dépression, le traitement doit durer minimum **6 mois à dose adéquate après la rémission** des symptômes (pas après le début du traitement).

En cas de dépression récurrente, un traitement de 2-5ans peut être prescrit, généralement à même dose que pour la phase aiguë.

Pour la schizophrénie, le traitement doit continuer 1an après la rémission complète d'un épisode aigu, ou 2ans après rémission complète s'il s'agit d'un deuxième épisode aigu.

En cas de diagnostic de schizophrénie avec des épisodes multiples et des symptômes résiduels, le traitement doit se faire à très long terme (pour ne pas dire à vie).

Psychothérapies

Qu'est-ce qu'une psychothérapie ?

Les théories des psychothérapies sont des principes fondant les relations thérapeutiques, mais ne peuvent pas être considérés comme des preuves de cause des symptômes. Ce sont donc des théories **narratives** mais non **étiologiques** des troubles.

Ce sont des traitements parmi les plus efficaces de la médecine, et le plus souvent curatifs.

C'est une forme de traitement qui vise un objectif thérapeutique défini, concerne des maladies psychiques et psychosomatiques, et se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques, ainsi que sur un diagnostic étiologique.

Ils sont limités à une **conversation** thérapeutique (+/- accompagnées de traitements médicamenteux).

Les séances sont agendées selon un calendrier et non prévues d'une fois à l'autre => définition d'un temps pendant lequel la discussion thérapeutique aura lieu. La durée de l'entretien est fixée préalablement et arbitrairement.

La psychothérapie nécessite l'**adhésion explicite** de la part du patient, sinon, elle n'aura aucun effet.

Le psychothérapeute doit conduire la relation, qui doit rester thérapeutique.

Peuvent aussi être des méthodes de développement personnel, pas uniquement comme traitement (mais alors pas de remboursement).

Chaque école peut proposer des thérapies destinées à différents types de personnes (couple, individuel, groupe, famille...).

Métier

La psychothérapie est un métier en soi. En Suisse, il y a un double titre : **psychiatre et psychothérapeute**. Ce n'est pas le cas en France ni en Espagne, où les psychiatres sont uniquement psychiatres.

Ainsi, la formation en 5 ans repose sur ces deux éléments : 5 ans de formation, dont 330h de théorie en psychiatrie et 270h en psychothérapie, 300h de pratique de psychothérapie, avec 150h de supervision, et 80h d'auto-psychothérapie.

Les psychologues psychothérapeutes suivent quasiment la même formation post-grade. Seule différence de pratique: les psychologues-psychothérapeutes ne sont remboursés que s'ils sont supervisés par un médecin-psychiatre.

Il existe également un CAS de médecine psychosomatique et psychosociale, qui permet à d'autres spécialistes de facturer les consultations en temps (et non uniquement en actes).

Naissance de la psychothérapie

1835 ; premier questionnement de la souffrance des patients délirants. Jusque là, on ne considère les pathologies psychiatriques que comme des troubles du fonctionnement. Découverte aussi des pathologies de l'**humeur**, sans symptômes délirants.

Au 20^{ème} théorie unifiée par Freud, sur le lien entre les pensées et les émotions.

Pinel et Esquirol découvrent l'importance du **traitement moral** : la posture bienveillante envers le patient est bénéfique. La relation de parole et la relation thérapeutique ont un impact.

Charcot: montre la *suggestibilité* des symptômes de l'hystérie par l'hypnose (définit celle-ci comme un critère diagnostic).

Bernheim : montre l'*effet thérapeutique* de l'hypnose sur l'hystérie.

L'hypnose devient ainsi la première psychothérapie reconnue : "psychothérapie hypnotique".

Paul Dubois conteste l'éthique de cette méthode (elle met les patients en dépendance), et instaure la méthode de discussion intellectuelle avec le patient, pour le convaincre des erreurs de jugements que comportent ses symptômes : "inculquer au patient la conviction qu'il va guérir. Par un effort de volonté, le patient doit se dégager de l'idée mère ou du sentiment qui motive le tic ou l'impuissance" => ancêtre des TCC.

Freud: critique d'abord la déformation de la relation thérapeutique, puis la propose comme objet du travail de la relation => Exploration de la déformation de relation avec le thérapeute, ou **transfert**, pour identifier ses origines et les traduire en "sens de la maladie".

Donc, les théories du 19^{ème} ont en commun :

- Les troubles psychiatriques sont des phénomènes psychiques
- Il est essentiel de nouer une relation thérapeutique
- Cette relation est spécifiquement basée sur la parole
- La participation active du sujet est requise
- La psychothérapie comporte une exigence de vérité à l'égard de soi-même

Reste en suspens : qu'est-ce qui est thérapeutique dans la relation ?

Le fait de pouvoir avoir un effet par la relation reste complexe et pas entièrement défini.

Il y a une part de suggestion et une part de persuasion.

L'histoire de la psychothérapie en Suisse est très riche (sociétés fondées dès 1919).

Au cours du 20^{ème}, la psychanalyse est devenue victime de son succès, et sa connaissance est devenue nécessaire pour de nombreux titres, y compris en littérature et histoire de l'art.

Elle est devenue bien au-delà d'une méthode thérapeutique, une **idéologie** et une façon de comprendre le monde entier.

Elle a ainsi finalement été contestée pour sa composante de relation de pouvoir.

Psychothérapies reconnues par la FMH et la FSP

Reconnues par les deux : Psychanalyse, TCC et systémique.

La FSP reconnaît aussi la thérapie *humaniste* et les *approches intégratives* (celles-ci ont essayé de prendre le meilleur des toutes les autres, mais sont devenues une école en elle-même).

Psychothérapie psychanalytique

1. Conceptions étiologiques : **Conflits intrapsychiques** inconscients déterminés par le passé infantile
2. Buts thérapeutiques: Résolution des conflits inconscients par la prise de conscience; traitement à visée curative.
3. Cadre: Nombreux dispositifs : en général durée et fréquence des séances fixes. Associations libres et abstinence. Le patient ne reçoit aucune directives, doit parler de ce qui le préoccupe. Une personne très peu loquace pourra donc difficilement bénéficier de cette méthode.
4. Technique : Attention flottante, neutralité bienveillante, interprétations des conflits et du transfert. Le thérapeute doit trouver les conflits intrapsychiques en écoutant mais avec une certaine

distance ce que dit le patient. Il ne doit pas prendre parti dans les conflits du patient, uniquement repérer les désirs contradictoires et aider le patient à les identifier.

5. Rôle du thérapeute, Disponibilité et présence maximum en évitant le plus possible de prendre parti dans les conflits
6. Durée du traitement : Variable : brèves (4 séances) ou longues (30 à 40 séances).

Psychothérapie TCC

1. Conceptions étiologiques : les symptômes proviennent d'un **apprentissage** dysfonctionnel déterminé par la relation entre la personne et son milieu.
2. Buts thérapeutiques : mettre en évidence les distorsions dans les cognitions, les émotions et le comportement.
3. Cadre : séances de durée variable, parfois longues. Nombre limité de séances.
4. Technique : très différente. Le thérapeute est très actif, et prend le rôle d'un expert spécialiste de toutes les idées dysfonctionnelles du patient. Il essaie de modifier ses idées, par exemple en confrontant le patient à ses symptômes phobiques et en renforçant ses comportements positifs (par des jeux de rôles).
5. Rôle du thérapeute : expert, dialogue socratique, conseil, exercices.
6. Durée du traitement : variable. Limitée dans le temps, 10-20 séances. Séances *boosters* (longues) pour les troubles de la personnalité.

Psychothérapie systémique

1. Conceptions étiologiques : Les symptômes sont pris comme des expressions d'anomalies de la **communication** déterminées par le contexte. A l'extrême, aucun diagnostic n'est pas posé (anti-stigmatisation). Peuvent aussi travailler en individuel, à partir des manières dont le patient se **représente** les communications.
2. Buts thérapeutiques : dépistage et modification des structures dysfonctionnelles pour une communication fonctionnelle
3. Cadre : séances assez longues (1h30), souvent avec un bilan en fin de séance.
4. Rôle du thérapeute : observe puis décrit et intervient sur la structure de communication dans le système
5. Durée du traitement: contrat limité dans le temps, parfois reconduit de séance en séance.

Analyse de vidéo (série “in treatment”)

1. Quel est le problème pour lequel Walter attend explicitement de l'aide? Ses insomnies. => pour partir sur les vrais problèmes, se baser sur les attentes explicites du patient.
2. Conflits intra-psychiques :
 - Représentations de sa fille : petit bébé, fragile, à protéger mais aussi personne admirable, entreprenante dont il est fier.
 - Enjeu plus général révélé par ce conflit : sa relation aux autres, qu'il a besoin de contrôler. Il a besoin que les autres aient besoin de lui. Son besoin de contrôle le met actuellement face à un problème du fait qu'il devra bientôt transmettre l'entreprise (il est vieux). Son vieillissement et la confrontation à la mort l'angoissent.
3. Personnalité de Walter : narcissique, égocentrique, méfiant, manipulateur, susceptible (=> paranoïaque)
4. Relation thérapeutique : l'échange commence par une conversation dirigée par Walter, il prend les commandes et dépossède le thérapeute de la gestion de l'entretien. Le thérapeute tente de le rassurer sur la stabilité de sa fille, mais ça ne l'aide pas. Il devrait prendre les deux aspects du conflit intra-psychique sans prendre position.

5. Proposition thérapeutique : valider la nécessité de consultation. Soulever le conflit intra-psychique et proposer de poursuivre l'exploration des deux facettes de la relation avec la fille.

Efficacité des psychothérapies

L'assurance de base ne rembourse que les traitements dont l'efficacité est avérée.

Les méta-analyses sont des méthodes statistiques qui permettent de montrer l'**amplitude** d'un effet. Celle de l'effet des psychothérapie est la plus importante comparé à d'autres traitements.

5-10% des patients vont moins bien après la thérapie.

10% restent inchangés.

Environ 30% vont mieux.

Le reste (et donc la majorité) sont entièrement guéris.

Généralement, l'évolution est linéairement lentement favorable.

Paradoxe de l'équivalence : Toutes les formes de psychothérapies, pour chaque problème, ont des résultats équivalents.

Les psychothérapies agissent sur les symptômes et sur le fonctionnement général.

Elles profitent rapidement à beaucoup de patients (patients répondeurs).

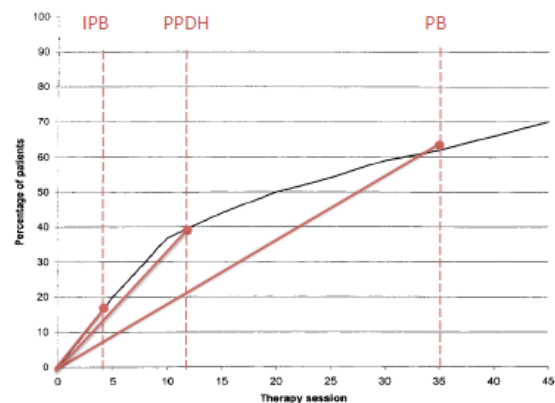
Courbe dose-effet :

Après les premières séances, la majorité des patients vont mieux. Mais il est difficile de savoir à l'avance le nombre de séances nécessaires. Pour ceux qui ont besoin de thérapies longues, l'effet semble supérieur.

Courbe noire : proportion de répondeurs.

Courbe rouge : courbe dose-effet pour un patient.

70% des psychothérapies durent moins d'une année.



Effet incubation de la psychothérapie: les résultats s'améliorent pendant le traitement, mais également *après* sa fin (apprentissage d'une façon de penser, qui permet l'amélioration même sans aide du thérapeute).

Autres approches thérapeutiques

Modèle bio-psycho-social

Concept de base

Tout sujet a certaines ressources, mécanismes de défense, vulnérabilité et encadrement, dont résultent des manifestations en cas de facteur de stress.

Ces manifestations peuvent être fonctionnelles et adaptées, ou être pathologiques.

Le traitement **bio-psycho-social** prend donc en considération tout ces mécanismes pour prendre en charge les manifestations.

La prise en charge psycho-sociale permet de nettement diminuer les facteurs de stress.

Les médicaments freinent les manifestations. Autres approches biologiques : stimulation transcrânienne et électrochocs.

Lieux de soins

Anciennement, la psychiatrie reposait sur le modèle asilaire : un seul lieu, de “mise à l’abri”.

A la fin des années 60, un mouvement (surtout en Italie) est né pour mettre en évidence les effets néfastes du traitement institutionnel.

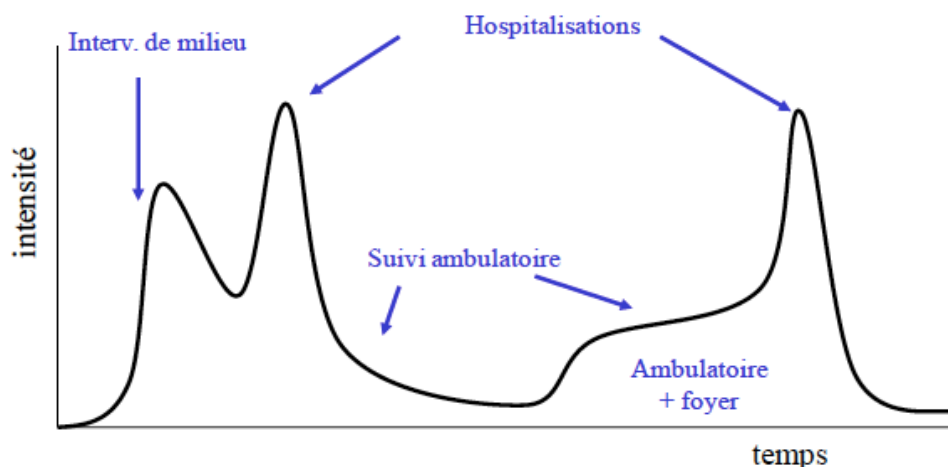
Actuellement, l’asile est remplacé par un vaste réseau de structures de soins dans la communauté : hôpital, polycliniques, hôpitaux de jour, centre de liaison, foyers de logements... En résulte une certaine complexité dans le suivi et la transmission des informations.

Les traitements **hospitaliers** tendent de plus en plus à être **brefs** (moins de 3 semaines) et à ne traiter que les aspects aigus, ce qui suppose un renforcement des autres lieux de prise en charge (intermédiaire, ambulatoire et communautaire).

Les structures intermédiaires sont : les hôpitaux de jour, les ateliers occupationnels, les foyers, les EMS et les appartements protégés.

Traitements ambulatoires : se font par des psychiatres installés et des médecins généralistes, qui collaborent avec des institutions publiques (le plus d’interaction possible),

Soins communautaires : les intervenants se déplacent au domicile des patients (se développe de plus en plus).



Coordination des soins : réseau

La chronicité qui caractérise souvent les troubles psychiatriques rend nécessaire la coordination de diverses formes d'intervention thérapeutique ou d'encadrement. Elle nécessite un travail en **équipe** et en **réseau**.

Les partenaires du réseau comprennent les médecins somaticiens, les services infirmiers et sociaux, les personnels des foyers, les éducateurs, les employeurs, les organes de l'AI, la police et les autorités judiciaires, les services pénitenciers, les associations, les familles, etc.

Les patients doivent parfois être dénoncés pour des transgressions de règles. C'est une marque de confiance de leur faire confiance qu'ils sont capables de comprendre les règles et de les respecter s'ils le veulent.

La psychiatrie : un monde en mouvement

Les modifications en cours dans la prise en charge publique des troubles psychiatriques chroniques :

- diminution marquée de la durée des séjours hospitaliers
- rôle accru des réseaux de soins communautaires
- de façon générale accentuation du côté «soins» au détriment du côté «contrôle social»

Ces modifications suscitent de nombreux débats parmi les acteurs engagés, et ne sont de loin pas encore bien maîtrisées.

Traitement non-volontaire

La plupart des traitements en psychiatrie sont suivis volontairement par les patients.

Il y a cependant (et c'est une spécificité de la psychiatrie) un certain nombre de situations où la prise en charge se fait sous contrainte. La relation médecin-malade en est modifiée, et cette modification doit être abordée clairement avec le patient. Ainsi, en 2013, près de la moitié des patients à Cery sont venus en PLAFA (placement à fin d'assistance).

La majorité des PLAFA sont **médicaux**, et un certain nombre sont sur décision de la **justice de paix**.

1. Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale¹ ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent être fournis d'une autre manière.
2. La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3. La personne concernée est libérée **dès que** les conditions du placement ne sont plus remplies.
4. La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Procédure

Le PLAFA est une décision juridique. Elle peut venir soit de la demande directe d'un juriste membre de l'autorité de protection de l'adulte, soit d'un médecin habilité à ordonner un placement par son canton (VD: tous les **MPR**, soit généralistes, pédiatres et psychiatres, ou un **médecin délégué**). Dans les deux cas, une expertise médicale est nécessaire.

La décision de placer la personne mentionne au moins:

- Lieu et date de l'examen médical

¹ intelligence limitée ou troubles de la personnalité

- Nom du médecin qui a ordonné le placement
- Résultats de l'examen, raisons et buts du placement
- Voies de recours (informer de la possibilité de recours et donner les moyens de le faire).

Le patient peut s'opposer à la mesure en écrivant une lettre au Juge de paix **dans les 10 jours**. La décision doit alors être prise dans les 5 jours, sur base d'expertise.

La durée du placement est de **maximum 6 semaines**, et l'autorité est obligée d'effectuer des examens périodiques pour déterminer si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. Pour durer plus de 6 semaines, la mesure doit faire l'objet d'une justification et d'une décision judiciaire.

La décision de l'arrêt de la mesure doit être faite par la même instance qui a ordonné le placement (autorité juridique ou médecin habilité).

Le PLFA n'est jamais une mesure punitive. Son objectif principal est de permettre à la personne concernée de retrouver indépendance et autonomie. Importance du principe de proportionnalité: la mesure doit atteindre le but fixé et si une autre mesure existe, elle devra être prise en priorité (voir aussi point 3.)

La Loi sur la santé publique dans le Canton de Vaud a introduit deux nouveautés importantes pour la psychiatrie :

- Les directives anticipées. P ex en cas de trouble récurrent, ce qu'il faut faire à chaque crise aiguë.
- Le rôle du « représentant thérapeutique »
- Depuis janvier 2013 : Traitement ordonné dans la communauté. L'autorité cantonale a également la compétence **d'ordonner un traitement ambulatoire** contre la volonté de la personne concernée.

Recherche translationnelle en psychiatrie

Contexte

La dichotomie entre réductionnisme biologique et chapelles psychothérapeutiques est dépassée.

Le nombre de troubles psychiatriques se comprennent comme le fruit de l'interaction entre :

- Vulnérabilité constitutive (à base biologique ou psychologique) et
- Facteurs de stress (psychologiques, biologiques ou sociaux)

Il est donc important de renforcer la collaboration entre cliniciens et chercheurs en neurosciences fondamentales de manière à promouvoir :

1. une meilleure connaissance des mécanismes qui sous-tendent les maladies psychiatriques ;
 2. des classifications qui reposent sur des bases plus solides ;
 3. la découverte de traitements plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des patients.
-

Limitation en psychiatrie clinique contemporaine

Deux problèmes centraux :

- 1) On ne connaît pas quel(s) est/sont le(s) mécanisme(s) biologique(s) impliqué(s) dans la très grande majorité des troubles psychiatriques.
- 2) Les classifications des maladies psychiatriques sont basées sur la seule observation clinique de par l'absence de marqueurs biologiques => plusieurs maladies d'origine différente mais de manifestation semblable sont donc traitées de la même manière.

Conséquences : impossibilité de définir des soins biologiques visant à traiter la cause des troubles, impossibilité à proposer des traitements différenciés selon le stade de la maladie, et impossibilité de mesurer l'évolution et la réponse au traitement au niveau biologique.

Actuellement :

Quasiment tous les traitements actuellement utilisés sont issus de la sérendipité (observation par hasard d'un effet).

Plusieurs modèles explicatifs des troubles psychiatriques n'ont été construits qu'à postériori, sur la base de ces observations (p ex théorie de l'excès de dopamine dans la psychose).

L'objectif actuel est donc de faire converger la recherche clinique et les neurosciences de base => **approche translationnelle**.

Exemple de la psychose

Développement nécessaire pour trouver des marqueurs biologiques (sujets à risque, sous-groupes de patients, monitoring) et des médicaments plus définis, adaptés au stade, et avec moins d'effets secondaires.

Une hypothèse : le déficit en glutathion contribue au développement de la schizophrénie. Le déficit en glutathion peut conduire indirectement à des lésions des neurones et perturber le fonctionnement de certains récepteurs. Des études de populations de schizophrénie chronique ont montré un déficit en glutathion préfrontal. => identifier des **biomarqueurs** pour l'intervention précoce.

Résultats : chez certains jeunes patients, on observe des déficits en glutathion, chez certains patients chroniques la situation est stabilisée (=> médicaments spécifiques, staging ?).

Conclusions

La recherche sur des **cohortes cliniques** permet :

- d'identifier des problématiques cliniquement pertinentes ;
- de développer des approches adaptées aux besoins des patients et
- d'évaluer l'impact de ces traitements innovants.

Les **approches neurobiologiques** permettent :

- d'explorer les mécanismes impliqués dans la maladie ;
- l'identification de marqueurs des divers stades et des diverses formes de troubles psychotiques ;
- le développement de nouvelles formes de traitements médicamenteux

La recherche **translationnelle** :

- crée un contexte dans lequel compétences cliniques et neuroscientifiques peuvent entrer en **synergie** ;
- est l'une des stratégies essentielles pour améliorer les traitement en psychiatrie contemporaine.